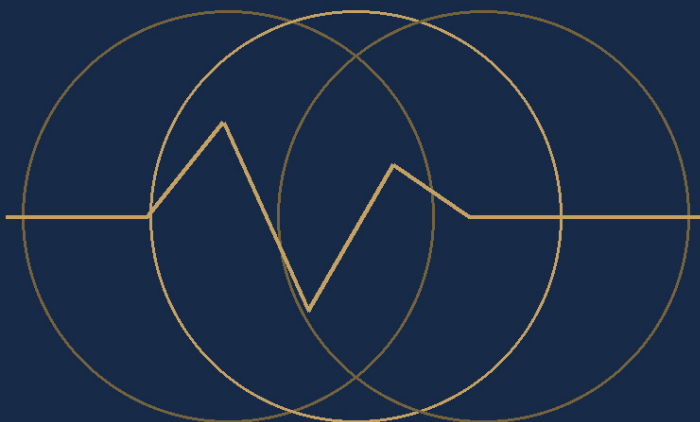


DEMAI MONOGRAPHS

德麦国际专著·第25号

心血管健康的 发生学重建

从风险控制到调节能力与生活重建



特征·自由·幸福

王德生、秦莉 著

The Generative Reconstruction
of Cardiovascular Health

德麦国际有限公司

出版信息

《心血管健康的发生学重建》

从风险控制到调节能力与生活重建

The Generative Reconstruction of Cardiovascular Health

王德生、秦莉 著

德麦国际专著第25号

出版机构：德麦国际有限公司（Demai International Pte. Ltd.）

ISBN：978-1-970820-33-1

版本：数字重编版 v1.0，2026年10月

本版沿用第25号专著的既有书名、联合署名与ISBN。本次为原稿的结构重编、文字统稿及医学证据校订，不是新增临床研究报告，也不表示已完成纸质新版的出版登记。原书未提供可核定价，本版不另行编造价格。

本书属于医学哲学与健康教育读物。SIO、SDE及意义三律用于提出问题、组织观察和讨论照护，不是已经通过临床验证的诊断系统。书中的教学人物与情境均明确标注构拟，不作为实际病例或疗效证据。涉及药物、检查和康复的内容用于帮助读者与专业人员沟通，不提供个人处方，不替代就诊，不据此自行停药、加药或改变服药时间。

原始材料：用户提供的《心血管三律医学入门》压缩包，内含11篇独立论文PDF及180页整书初稿。整书初稿另含5项长篇专题，本版按全部16项材料重构，而非只处理独立文件。重复摘要、目录、平台提示语、聊天痕迹及示例性参考文献已作清理；涉及临床数据、药物因果和实践安全的实质修订，见附录四。

编辑方式：AI辅助整书重编与证据校核。原作者的理论命题、公开医学证据、编辑新增的说明与构拟案例，在正文中区分呈现。医学资料核查截至2026年10月2日；此后读者应以当地适用的最新专业规范和自己的临床评估为准。

© 王德生、秦莉。本版文本用于本书的授权出版与阅读。引用请注明书名、作者、版本及具体章节。对理论的引述不应截去其适用范围、证据边界或修正说明。

作者与本书

王德生，SIO主客互动与SDE发生学理论的提出者，持续从数学、哲学、教育及跨学科实践之间展开研究。本书延续他的一个基本问题：事物不仅以已经完成的结果呈现，也在关系、条件与差异过程中不断形成；人的健康同样不能只从一张完成态的检查单加以理解。

秦莉为本书共同作者，本版沿用第25号专著既有联合署名。现有出版资料未提供可逐项核验的个人履历，故本版不增写其职务、专业资质或从业经历。

这不是一本把哲学词语换成医学名词就宣称完成了临床突破的书。它希望在现有的诊疗证据之上，增加一层对生活过程的追问：患者怎样进入治疗，哪些选择实际可行，怎样知道一个计划正在帮助他而不是耗尽他。作者提出的框架也必须接受相同的追问；一个表达得漂亮的体系，并不因此自动获得疗效。

前言 不能只把人送回正常值

医学要保护人的生命，也要给被保护的生命留下可以生活的空间。

有一个场景，贯穿了组成这本书的多篇原稿。一个人带着检查单走进诊室，几个数值被圈出来，几个目标被写下去。他开始记住许多新词：血压、血脂、糖化血红蛋白、危险分层、复查时间。以后的一段日子，吃饭之前想的是这口食物会不会使数字升高，出门之前想的是药有没有带，体检之前想的是这一回能不能过关。他当然希望自己安全，却也可能在反复管理安全的过程中，渐渐不知道安全是为了怎样的生活。

这个场景不是一份实际病历，也不是对所有医生或所有患者的描写。它是本书用来打开问题的一幅教学图景。它提醒我们，一个临床目标即使有充分依据，仍然可能在传递、执行和考核中变得狭窄。减少脑卒中风险的必要工作，可能被误解为随时随地追赶某一个读数；帮助患者长期生活的计划，可能被执行成一套他根本承担不起的每日任务。被漏掉的并不是另一种神奇药物，而是这些目标与这个人的日常如何接在一起。

原稿为这种遗漏提出了强烈的抗议。它反复追问：为什么数值改善了，人却仍然疲惫？为什么我们能够说清一种药如何作用，却说不清一位夜班工人怎样安排睡眠？为什么“依从性不足”常常先成为对患者的判断，而工作时间、照护负担、费用和恐惧却没有同样清楚地进入记录？这些问题值得保留，而且值得写得比口号更深入。一个人不是指标的容器，慢性病照护也不能只有指标的进出账。

然而，抗议的力量不等于论证的完成。早期文章中，一些句子把“不能只看指标”推成了“指标没有因果作用”，把“需要关注药物负担”推成了“药物必然使身体失去调节能力”，又把“治疗之后仍然有人发病”当成“治疗无效”的证据。这样一来，对片面的纠正又制造了另一种片面。最需要保护的读者，可能在获得一种新的解释时，失去了对现实风险的正确判断。

因此，这次重编并不把这些矛盾藏起来。一个信号可以提示上游问题，同时继续参与下游损伤；一种治疗可以降低风险，同时需要监测不良反应；一位患者可以需要长期药物支持，同时拥有充分的主体性。它们并不互相排斥。只要承认这些关系，本书原来最有价值的问题就不必依赖夸张的医学断言才能成立。我们完全可以既认真对待血压、血脂与血糖的危险，又拒绝把患者缩减为这些危险的载体。[1—9]

“发生学重建”要处理的，正是这种同时性。某个结果是怎样形成的？哪些条件维持着它？一次干预除了改变当前读数，还改变了下一次行动的可能性吗？患者在治疗之后是否更能理解自己的状况，更能与他人沟通，更能获得可以持续的支持？这些问题把一个静态的好坏判断，展开为一段需要观察、比较和修正的过程。它不是让医学停止测量，而是让测量回到过程之中。

这里也需要对医学史保持公允。生物—心理—社会医学、循证医学中的临床判断、以人为中心的照护和共同决策，早已提出过许多整体性要求。我们不能为了证明一个新框架有用，就把已有医学描写成完全没有心理、社会与个人选择的机器。恩格尔对医学模式的批评、萨克特等对循证医学的说明，以及共同决策的专业规范，都使这种简单对立难以成立。[20—22] 本书的任务不是抢占“第一个重视人”的位置，而是尝试把这种重视变成更细致的观察与行动组织。

意义三律为这一尝试提供了三个相互牵连的问题。特征律问：我们是否看见了这个人这个情境中的具体差异？自由律问：他是否拥有不止一条实际可走、且能根据反馈调整的路径？幸福律问：被延长和被保护的生活，是否仍然与他愿意珍惜的事情相连？这三个问题都不能单独作王。特征不能成为拒绝一切公共证据的理由，自由不能成为忽略危险的许可证，幸福也不能成为用眼前舒适否定长期保护的借口。

三律首先约束的是我们怎样组织问题，而不是替某个分子、器官或药物直接宣判。免疫、神经和内分泌之间存在复杂联系，但不能据此把一个系统指定为某一律的唯一生理实体。身体的调节并不等于人的有意识选择，细胞也不会像人一样开会决定“值不值得”。在本书中，这类拟人化表达只有在明确作为比喻时才可使用；一旦进入机制、诊断和疗效的层面，就必须交还给可检验的专业证据。

同样，本书不会把“自然”与“人工”安排成善恶两端。药物、眼镜、助行器、监测设备、可靠的家人和社区服务，都可能成为一个人继续行动的条件。真正需要警惕的不是外部支持本身，而是支持是否失去解释、缺乏反馈、不可负担，或者把患者的声音排除在外。一个借助药物仍然可以工作、散步和照顾家人的人，并不比一个暂时不需要药物的人少了什么人格上的完整性。

书中的“重建”也不许诺每个人都能回到没有疾病的过去。不同病程、不同器官损伤、不同遗传背景和不同生活条件，能够改变的范围并不相同。重建有时表现为风险下降，有时表现为症状得到解释，有时表现为一项无效负担被撤除，有时则表现为一个人在承认局限之后，仍找到了愿意继续的生活。能够持续修正，比宣布彻底翻案更困难，也更接近我们希望给予读者的帮助。

本版把原来的16项文章材料重新组织为六编三十章。前两编建立问题框架和证据纪律，中间三编分别处理血脂、血压与血糖，最后一编回到门诊、家庭、制度、智能工具与研究。它不是把原来每篇文章再写一遍，而是清除重复、接通论证，并把原来散落在愤怒中的关切转成能够讨论的命题。读者应当能沿着同一条线，既看见理论的雄心，也看见它应当停止的地方。

医学需要发现危险，生活需要发生可能。两者之间不应是一场谁消灭谁的战争。我们不必先否认风险，才有资格谈自由；也不必先把自由交出去，才有资格得到保护。这本书真正想重建的，是这样一种关系：证据帮助人不被误导，人也使证据不被执行成一套失去目的的任务。正常值不是终点，离开正常值也不是自由；值得追求的是，一个人能够在可靠的保护中，重新参与自己的生活。

导读 沿着三条线读这本书

本书可以从一个非常普通的问题开始：这项健康安排，到底改变了什么？只回答“改变了一个数值”太少，只回答“改变了整个生命结构”又太空。比较可靠的回答，应当逐步说明它改变了哪些可观察的结果，经过怎样的过程，依赖哪些条件，付出了什么负担，以及这些改变对当事人意味着什么。全书围绕这个回答展开，不要求读者先背熟哲学缩写。

第一条线是证据线。凡是涉及血脂是否参与致病、降压是否减少事件、不同降糖治疗如何选择之类的问题，本书都会把答案放回临床研究与专业规范。这样的知识不由一个漂亮比喻决定，也不由某个个案的好运或坏运决定。一个人服药后仍然发生脑卒中，并不能单独证明服药造成了脑卒中；一个人血脂偏高但暂时没有事件，也不能单独证明长期暴露没有危险。第二编专门解释这些容易混淆的地方，附录提供本次修订中撤回或改写的典型命题。

第二条线是过程线。假设一个方案有证据支持，我们还需要知道它怎样进入生活。一次抽血不能完整描述一个人的饮食条件，一句“规律运动”不能自动变出安全的活动空间，一项治疗也不会因为写在处方上就自然成为可持续的行动。过程线关心的是先后次序、实际障碍、恢复机会以及下一次复评。它把“应该做”进一步追问成“由谁，在什么条件下，怎样做到，怎样知道需要改”。这正是发生学视角最希望贡献的部分。

第三条线是意义线。风险控制是为了让人继续生活，而不是为了使生活永久围绕风险旋转。一个人可能希望保住工作能力，也可能最在意避免跌倒、减少夜间打扰、独立走到附近的菜场，或者继续与家人吃一顿不充满争吵的饭。意义线要求这些目标

被清楚说出，但不会让它们取消医学事实。共同决策不是患者想怎样就怎样，也不是医生解释之后患者只能同意，而是在事实、选择、负担与个人目标之间共同形成可追踪的决定。[20]

三律与这三条线有联系，却不是一一对应的三张标签。特征律不只处理医学证据，自由律不只处理行为训练，幸福律也不只处理感受。一个夜班安排，会同时改变测量的解释、服药的可行性和家庭共同生活的时间；一次药物调整，也可能同时影响风险、费用与行动自由。阅读时，不妨把三律当作反复换位的提问，而不是把一切事物永久塞入某个格子。

第一编适合希望理解本书立场的读者。它解释为什么指标、功能、个人感受和生活条件都重要，也说明SIO与SDE两个框架之间的区别。第二编适合那些经常看到“某项研究彻底推翻医学常识”消息的人：它讨论信号、原因、风险、阈值和证据，帮助读者不被强烈措辞牵走。第三至第五编可以按个人关切阅读，但不要把其中的药物讨论当作给自己的处方。第六编与附录则可用于准备复诊、整理问题和设计可接受检验的研究。

书中有几种不同的文字。章首短句提出问题，不是临床结论。标明“教学构拟”的人物和对话，用来展示决策困境，不代表真实患者，也不证明一种方法有效。带参考编号的医学陈述，可沿着书末文献追溯。每章最后的“带走的话”只帮助记忆，不能替代该章的限定条件。阅读时发现短句与完整论证似乎冲突，应当优先看完整论证，并把这个冲突视为值得反馈的编辑问题。

本书不提供所谓三律健康总分。没有经过验证的量表，即使拥有小数点、雷达图和算法界面，也不会因此变得可靠。附录中的记录页仅帮助读者把症状、测量情境、治疗安排、实际困难和待问问题整理在一起；它不能诊断“幸福律崩塌”，不能预测某天是否心梗，也不能决定何时停药。简明工具的价值，在于减少沟通遗漏，而不是制造另一套未经证实的权威。

有几件事情不应等待阅读完成。出现疑似心梗或脑卒中的突然症状，应立即联系当地急救服务；出现意识改变、严重呼吸困难或其他急症，也不应先试本书讨论的放松、散步或记录方法。胸痛和神经系统症状不能先被归为情绪问题，血糖异常也不能先被解释为“身体在表达自由”。关于急症边界，本书在相应章节及附录三作了集中提醒。[23]

最后，读者不需要接受全书的理论，才能使用其中的好问题。即便你对发生学、三律或主客互动持保留态度，仍然可以要求治疗目标被解释、症状被认真听取、研究结论不被夸大、家庭负担被看见、失败被记录。一个框架如果只有在全盘信奉之后才有用，它就很难服务真实的医疗生活。本书愿意把自己放在这种检验之下：它能否使讨论更具体，使决定更可修正，使人得到更可靠而不是更神秘的帮助。

目录

页码为PDF物理页序，含封面与前置页。

出版信息	2
作者与本书	4
前言 不能只把人送回正常值.....	5
导读 沿着三条线读这本书.....	8
第一编 把健康还给一个完整的人.....	13
第一章 体检单之外的那个人	14
第二章 三律不是三个科室	17
第三章 SIO与SDE：从对象走向发生	20
第四章 免疫、神经与内分泌：联系不等于同一	23
第五章 指标、能力与意义：三种尺度不能互相吞掉	26
第二编 从“翻案”走向可以检验的因果.....	29
第六章 信号也会伤人.....	30
第七章 正常不是同一种线	33
第八章 故事、机制与试验，各自能证明什么	36
第九章 代偿、适应与损害的边界	39
第十章 协同不是把更多项目装进生活	42
第三编 血脂与血管：越过敌人的隐喻.....	45
第十一章 LDL不需要被妖魔化，也不能被免责	46
第十二章 斑块不是水管里的油垢	49
第十三章 从他汀到组合策略：获益、负担与剩余风险.....	52
第十四章 心梗与脑卒中：不能等待解释完毕的边界	55
第十五章 血管重建不靠冲洗	58

第四编 血压：让风险与节律同时进入诊室.....	61
第十六章 血压怎样发生.....	62
第十七章 测量、曲线与被误读的个体	65
第十八章 降压药作用于什么	68
第十九章 头晕、疲惫与被遗漏的治疗负担	71
第二十章 个人节律不是统一的时刻表	74
第五编 血糖：让代谢与生活共同持续.....	77
第二十一章 胰岛素不是敌人	78
第二十二章 降糖药物图谱：从名称判断走向具体权衡	81
第二十三章 糖化血红蛋白不是奖牌	84
第二十四章 缓解不是治愈，也不是所有人的义务	87
第二十五章 吃饭、活动与愉快不是三个敌人	90
第六编 让健康发生的共同工程.....	93
第二十六章 一次门诊需要两种记录	94
第二十七章 一段可修正的重建过程	97
第二十八章 医疗制度把什么奖励出来	100
第二十九章 AI与知识生态：不让新仪表接管人.....	103
第三十章 让三律先接受自己的检验	106
结语 让被保护的生命重新生活.....	109
附录一 术语与阅读边界.....	111
附录二 复诊与生活观察页.....	114
附录三 安全边界与急症提醒.....	116
附录四 原稿对照与实质修订说明.....	118
附录五 三律支持研究的可检验提纲.....	122
参考文献与资料来源.....	124
版本后记	128

PART

第一编 把健康还给一个完整的人

本编先不讨论应该吃哪一种药，也不许诺一种全新的疗法。我们先把问题摆完整：一个可测量的身体、一个能够行动的人，以及一段他愿意继续的生活，怎样在健康照护中同时出现？三律不是替其中任何一项夺取统治权，而是防止它们互相吞没。

CHAPTER

第一章 体检单之外的那个人

指标可以告诉我们许多重要的事，却不能替一个人把生活讲完。

一、两种真实，不必争夺唯一的位置

设想这样一个教学情境：周先生刚过五十岁，带着复查结果走进诊室。医生看到几个风险指标已经改善，认为当前治疗有帮助。周先生也认可这些变化，却补充说，最近下班以后很难再陪孩子走一段路，夜里反复醒来，对自己每天需要完成的健康任务感到疲惫。这里至少有两种真实：经过核实的指标改善，以及尚待解释的生活困难。它们可以同时成立。前一种不能自动否定后一种，后一种也不能自动推翻前一种。

对周先生最不利的回答，是迅速选一边站队。“检查好就说明你没问题”，会使症状被忽略；“不舒服就说明治疗把你伤害了”，又会过早锁定原因。症状可能与原有疾病、另一种疾病、睡眠、情绪、工作安排、药物影响或多种因素有关。可靠的工作不是先把它收编进一个宏大的解释，而是让时间关系、具体表现、伴随情况和必要评估进入讨论。一个理论应当帮助我们提出更多可以分辨的问题，而不是使问题提前结束。

二、当手段替代了目的

指标之所以重要，是因为它与某些值得避免或争取的结局有关。减少心脑血管事件、延缓器官损伤、改善症状、保住活动能力，都是比“让报表漂亮”更实在的目标。临床研究会区分替代指标与患者重要结局，专业决策也需要考虑收益、风险和个人条件。[2][3][9] 本书的批判不是说医学从未做过这些区分，而是指出：这些区分在日常执行中可能丢失。一个原本用于帮助决定的数字，可能变成无需再解释的命令。

假如周先生说，他最怕的不是少走几步，而是因为反复不适失去工作，问题就改变了。我们需要问，当前困难是否影响安全工作，哪些检查或调整有必要，哪些健康任务可以简化，哪些生活条件需要家人或单位参与。若最后只得到一句“再坚持一下”，他的实际处境仍然没有被处理。与此相反，如果为了让他当下轻松，就随意取消有明确必要性的治疗，同样没有尊重他的长远利益。目的不能被指标替代，也不能被一时的感受独占。

三、身体不是被主体随身携带的工具

原稿用“生成性结构”反对一种常见想象：仿佛人先完整地存在，再带着一副偶尔需要修理的身体去生活。在发生学视角下，人的行动能力、习惯、关系与身体状态始终交织。一个人能不能出门，不只取决于肌肉，也取决于楼梯、交通、信心、陪伴以及医生解释过的活动边界。这里没有哪一个因素可以独自代表全部健康，但也不能因此说任何一个因素都不重要。

这使“恢复”获得了比修复一个零件更丰富的意思。对于同样的身体条件，一个可以步行到附近公园、知道怎样处理不适、愿意求助的人，与一个因为恐惧而完全不敢出门的人，可能拥有不同的日常行动空间。我们可以据此提出照护问题，却不能直接宣布第二个人的疾病是恐惧造成的。关系影响行动，行动影响观察，观察又影响后续决定；这是一条值得具体研究的链，不是一句可以包办病因的结论。

四、把“我不舒服”写成可以回应的信息

个人感受并不因为难以量化就失去价值，但它需要被表达得更清楚。“吃药以后整个人不行了”，可以进一步展开为：何时开始，主要发生在一天中的哪个时段，站立时是否明显，是否与进食或活动有关，有没有同时改变其他药物或生活安排。这样的细化不是审问患者是否说真话，而是让他的真实经验获得被专业判断接住的形式。相反，要求每一种感受先被仪器证明才允许进入讨论，也是不恰当的。

我们还应允许一个人说不清楚。并不是所有人都能在短暂门诊里准确描述身体变化，有人害怕被认为矫情，有人把不适视为衰老理所当然的结果，也有人长期替家人着想，习惯把自己的问题放到最后。照护不能只奖励表达流利者。一个简明的问题清单、一段不被打断的叙述时间，或者患者同意参与的家人，可能帮助遗漏的信息出现。这些方法的具体效果需要评价，但它们至少明确了应当保护的交流条件。

五、完整不是无所不包，而是不提前删掉人

完整地看待健康，并不意味着每次都做所有检查、邀请所有专业、填写所有量表。那样可能把整体照护变成更重的负担。所谓完整，是在做选择时知道自己看到了什么、尚未看到什么、为什么暂时不做某件事，以及出现什么变化需要重新考虑。它是一种有边界的开放，而不是无穷无尽的信息收集。

回到周先生，合理的下一步不一定是更复杂的理论，也不一定是更多药物。可能需要的是核实不适、解释已有治疗的目的、确定一个最重要的生活目标，然后约定怎样复评。最终方案由临床情况决定。本书在这里增加的是一个不能被省略的问题：我们保护的这个人，接下来准备怎样生活？没有这个问题，照护容易只留下数字；有了这个问题，数字才更清楚地知道自己为什么重要。

带走的话：既不让指标堵住人的叙述，也不让叙述跳过对风险的核实。

CHAPTER

第二章 三律不是三个科室

特征、自由与幸福，是三个彼此校正的问题，不是三张给身体贴上的标签。

一、从“这一类人”走向“这个人”

特征律在本书中的第一层含义，是要求区分。相同的疾病名称下，病程、合并疾病、用药经验、工作安排、经济条件与个人目标可能不同。看见这些差异，不是取消分类，而是防止分类取代全部判断。我们需要“高血压”“糖尿病”等公共语言，才能交流风险与研究证据；但这类语言并不自动包含某一位患者全部的处境。

特征也不等于任性。“我的身体特别，所以任何标准都不适用”，不是一个已经成立的医学结论。特征必须通过可观察、可讨论的差异进入判断，例如测量条件、治疗耐受、肾功能、跌倒史或具体照护安排。一个不能说明差异在哪里、却要求免除一切证据约束的“个体化”，最终可能比标准化更随意。特征律要使判断更精细，而不是使判断失去共同基础。

二、自由不是完全不借助外物

自由律关心的是可行路径。一个计划即使理论上合适，若患者没有时间、费用、交通或必要技能，就可能只是一张纸。让人多拥有一条安全可走的路，可能比再增加一条要求更重要。例如，在不改变临床目标的前提下，医生与患者讨论怎样减少执行困难、怎样获得可靠的复诊支持，属于增加实际选择，而不是放松对健康的责任。

原稿把外部药物支持与身体自由直接对立，容易造成误解。外部支持有时替代某些环节，但也可能使更高层次的行动重新成为可能。眼镜改变了视觉条件，却不因此剥夺阅读自由；对于有明确需要的人，胰岛素同样可以成为维持生命和生活的必要条件。[9] 判断支持的价值，应当看它的证据、适应证、负担和实际后果，而不是只看它是否来自身体之外。

因此，自由律必须同时讨论“能够做”和“能够不做”。一个人应能提出疑问，了解替代方案，知道继续原方案的理由，也知道什么情况下应当重新评估。自由不是让他独自承担专业判断，而是使他不被排除在与自身生活有关的决定之外。被解释过的边界可以增加自由；没有解释的放任，反而可能把一个人交给风险。

三、幸福不只是一次舒服的释放

幸福律把照护重新接到生活意义上。原稿常用“张力—忍耐—释放”描述它，这个比喻能帮助我们注意持续压力与恢复机会。但人的幸福不能被缩减为每次排尿后的轻松、每次运动后的愉悦或某一种神经递质。生活中也有需要承受的治疗、需要等待的恢复，以及暂时并不舒服却值得坚持的安排。把不舒服一律判成违背幸福律，会使这个概念失去判断复杂处境的能力。

本版将幸福律理解为一个持续的价值追问：这项安排是否仍然服务于当事人珍惜的生活，是否在可接受的代价下保存了希望、关系和行动空间？这不是宣称一种统一的幸福配方。有人珍惜独立，有人珍惜陪伴，有人把稳定工作看得很重，也有人更在意减少治疗对晚年日常的打扰。价值差异需要在安全边界和知情讨论中被认真对待，而不能由编辑、医生或算法代为宣布。

四、三律为什么不能分别打分后简单相加

设想一个教学情境：某项计划可以降低风险，但需要患者频繁奔波，费用也使家人紧张。若只看风险，可能忽略执行困难；若只看负担，可能错过必要保护；若只看当下的满意程度，又可能把长期问题排除在外。这里需要的是在多项要求之间重新组织方案，而不是随手给特征、自由和幸福各打七分，计算一个总分之后宣布合格。

三律之间存在冲突，也存在相互支持。为了减少某种严重危险，短期内可行选择可能变少；为了增加长期行动能力，有时需要经过不太愉快的学习或康复过程。关键不在于任何时刻三项都最大，而在于谁作了取舍、依据是什么、代价由谁承担、何时可以修正。这样的提问，比“凡是抑制就有害，凡是激发就有益”更能面对真实的医疗问题。

五、三界是观察入口，不是三个病因箱

原稿将理念界、现实界与自我界同三律相交，形成九种观察组合。本版保留这一组织思路，但不把它当作九种已经验证的疾病分类。理念界可帮助我们考察“患者和医护怎样理解健康”；现实界可帮助我们考察“身体、物质条件与实际行动怎样组织”；自我界则提醒我们注意“当事人怎样体验、判断与承担”。它们是哲学上的观察入口，不是互不相通的三个器官。

例如，一个人认为“只要吃药就不必再改变生活”，属于可讨论的理解；他的工作使他很难按时休息，属于实际条件；他担心承认困难会被家人责备，属于体验与关系中的判断。三者互相影响。把它们写清楚，可以增加照护的可见性；但不能因此宣布某一格失衡就是高血压的真正病因，更不能凭九宫格替代医学评估。框架帮助我们展开问题，证据帮助我们判断哪些解释站得住。

带走的话：特征使判断具体，自由使路径可走，幸福使保护仍然有目的。

CHAPTER

第三章 SIO与SDE：从对象走向发生

不只问身体现在是什么，也问它怎样成为现在这样，以及下一步怎样可能不同。

一、关系不是事后添加的背景

SIO的三个字母在本书中分别指主体、互动与客体。它们不是三种固定材料，而是对一个具体关系的分析。患者在就诊中是参与判断和承担后果的主体，检查、药物与疾病信息成为他需要面对的对象，解释、讨论、执行与复评构成互动。换到另一种分析尺度，医生、团队或某个生理系统又可能成为研究中的行动单位。因此，每次使用SIO，都要说明分析的层级与对象，不能在一段话里从患者跳到细胞，再把二者的“主体性”当成同一件事。

这一要求看似琐碎，实际上能阻止许多漂亮而含混的推论。如果我们说“药物压制了主体”，需要问：这里的主体是患者的决定权，还是某条生理通路的活动？前者涉及知情、沟通与自主，后者涉及药理与生理机制。二者可能有关，却不能互相代证。抑制某条异常活跃的通路，不等于剥夺患者人格；让患者参与选择，也不等于该选择一定有生理益处。SIO的价值在于把这些关系区分清楚，然后讨论它们怎样连接。

二、从一个结果追问一段形成过程

SDE把注意力进一步引向发生。按本书采用的理论术语，S是显露，D是差异序列，E是特征纠缠。显露不是永远不动的实体，而是某种状况在条件中呈现；差异序列不是泛泛的“运动”，而是先后变化及其组织；特征纠缠也不是能量的别名，而是使各种特征相互牵连、难以孤立解释的条件结构。三个词帮助我们避免只盯住完成态的结果。

在一个教学例子中，同一位患者两次复诊的血压读数相似，但两次读数的形成过程并不一定相同。第一次测量之前刚匆忙上楼，第二次经过规范休息；第一次用药情况不清，第二次已有连续记录。读数是我们要看到的显露，测量前后的次序属于差异过程，而仪器、姿势、用药安排、工作和睡眠等条件影响我们怎样解释它。这个例子不是用SDE取代测量规范，而是用SDE提醒读者：脱离形成条件的读数，可能被过度解释。[1][2]

三、三方方程是关系约束，不是现成的医学计算器

SDE以三组关系表达互相规定： $S=F(D,E)$ ， $D=G(S,E)$ ， $E=H(S,D)$ 。在本书的哲学用法中，它们强调显露、差异序列与特征纠缠不能彼此孤立。看到当前结果，可以追问形成它的过程与条件；设计一段过程，需要考虑当前状态和支持条件；改变条件，也要观察它怎样影响后续状态和行动。

但这里的F、G、H并没有因为写成函数就自动获得数值形式。要成为可用于预测或诊断的医学模型，还必须定义变量、说明测量方法、估计参数、检验误差、验证适用人群，并与已有方法比较。本书没有完成这些工作，因此不会把三方方程当作能够算出用药剂量或发病概率的算法。形式表达可以组织研究，但它不能替尚未完成的研究出具证明。

四、一次改变为什么需要回写

假设一位患者与团队商量后，尝试把原本过重的健康任务简化为一项可持续行动。发生学关心的，不只是他有没有完成任务，还包括这次尝试改变了什么条件：是否获得家人支持，是否更了解自己的困难，是否发现原计划不适合自己的工作节奏。下一轮方案应当利用这些信息，而不是每次都把失败解释成患者不够努力。

这种把结果带回下一次判断的做法，本书称为回写。它不要求神秘技术。一张写清楚“做了什么、出现什么、什么没有发生、接下来改什么”的记录页，就可以承载基本回写。重要的是，失败也有位置。若只记录漂亮结果，把无效、不适、退出或执行困难删掉，所谓自增长的健康知识就可能越来越自信，却越来越偏离当事人的生活。

五、同一个标签，并不意味着同一种下一步

“血压仍未达目标”是一个需要认真处理的结果，但它不能自动决定所有后续细节。测量是否可靠、当前方案是否真正执行、是否存在不良反应、是否需要排查其他原因，以及患者能否获得复诊，都可能影响下一步。^{[1][2]} 发生学视角要求把这些形成条件组织起来；它不会因为问题复杂，就取消对持续高血压的管理。

同样，“觉得好一些了”也是有价值的结果，却不能单独证明风险已经解除。人可以在感受改善时仍需要长期保护，也可以在指标改善后继续需要症状评估。SIO帮助我们看见谁在与什么发生关系，SDE帮助我们看见关系怎样改变。二者合起来，应当使我们更耐心地追问证据与过程，而不是更快地宣布一种整体解释已经胜出。

带走的话：三方程可以帮助我们追问发生条件，不能替未经完成的医学验证作答。

CHAPTER

第四章 免疫、神经与内分泌：联系不等于同一

生理系统之间确实相互联系；一个三分框架却不能因此成为三种系统的身份证。

一、为什么这个类比有吸引力

原稿尝试把免疫、神经与内分泌，同特征律、自由律与幸福律放在一起理解。这个尝试有直观吸引力：免疫使人想到识别，神经使人想到响应和调节，内分泌使人想到全身协同。通过这种联系，普通读者可能更容易意识到身体并不是一堆互不相关的零件。作为启发式类比，它能够打开阅读；但若进一步声称三个系统分别就是三条律的生理实体，问题便出现了。

任何一个系统都不只承担一种抽象功能。识别、反馈、协调和适应并不是某一个系统的专利；同一系统在不同层级、不同状态下也可能产生有利或不利的结果。人体的心理状态与心血管健康之间存在值得研究的相互关联，但这些关联涉及多种行为、生理与社会路径，不能用一一对应的标签穷尽。[29] 三律可以提出跨系统的问题，却不应拿走各学科已经区分出来的机制。

二、从分子到人，不是把同一个词放大六次

本书讨论的对象跨越分子、细胞、组织、器官、系统和人的生活等层级。层级之间当然有关，但相关不等于可以直接换算。某种分子信号增强，不意味着整个人的自由增加；某条通路受到抑制，也不意味着他的幸福减少。若跳过中间层级，就可能把一个药理事实迅速翻译成一项价值判决，而没有真正证明二者之间的连接。

例如，描述一种药“阻断受体”，属于机制语言。它对症状、器官结局、活动能力或生活质量产生什么影响，需要另外的研究与观察。“阻断”这个字在日常语言里带有被限制的意味，但药理上的抑制并不因此成为伦理上的压迫。反过来，某个方法被称为“激活”，也不能据此判定它有益。异常活动有时恰恰需要抑制，是否值得干预取决于具体情境，而不取决于动词听起来是否积极。

三、身体的“判断”是一种需要说明的语言

原稿把生命描写为不断判断自身特征、通路和价值的系统。本书保留这种哲学表达的启发性，但必须说明：在谈细胞或组织时，“判断”不是说它们拥有与人相同的意识、理由或意图。它可以指对条件差异作出有选择的反应，也可以指研究者用来组织功能关系的模型语言。若要进一步主张某种特定的认知能力，就需要相应证据，不能从拟人化修辞直接推出。

这一界限也保护患者。器官功能下降不能被说成身体判定这个人“不值得继续”，疾病进展更不能被解释为他缺少意义、没有正确表达情绪或失去了存在资格。这样的表达既不能成立为临床说明，也可能给患者增加不应承担的道德负担。一个人即使长期痛苦、表达困难或需要外部照护，也不会因此失去被认真治疗和尊重的资格。

四、比喻要把我们送回问题，而不是带离问题

一个好比喻的作用，是让不容易看见的关系变得可问。把长期压力比作没有出口的张力，可以帮助我们询问休息与支持；把健康计划比作道路，可以帮助我们检查障碍与替代路径。但比喻到此还没有完成医学工作。夜间睡眠困难应怎样评估，药物是否造成某种不适，某项运动是否安全，都不能由“把张力放出去”几个字直接决定。

我们可以给比喻设置一个简单的退出条件：当它开始用于解释具体病因、预测结局或建议治疗时，就必须转成可核实的命题。说“这个安排让人喘不过气”，可以是生活叙述；说“喘不过气只是被压抑的情绪”，就已经越过了边界。后者可能漏掉需要及时处理的身体问题。保留语言的温度，不意味着放弃判断的精度。

五、让三律成为跨学科讨论的邀请

比较稳妥的用法，是把三律变成跨学科讨论时的三组开放问题。哪些差异被目前的解释忽略了？哪些连接或替代路径值得进一步研究？哪些结局对当事人重要却没有被记录？免疫学、神经科学、内分泌学、心理学和社会研究可以分别提供答案的一部分，也可能指出问题本身问得不准确。三律需要允许这种纠正，否则跨学科就会退化为用其他学科替自己的概念作装饰。

本章并不削弱整体观，而是使整体观免于空洞。一套理论若声称自己能够解释所有层级，却无需任何层级的独立证据，它就很容易把所有结果解释成自己正确。相反，愿意明确“这里是类比，这里是机制，这里仍然不知道”，才能让理论进入真正的合作。联系需要研究，同一需要更强的证明；两者之间的距离，不应被热情抹去。

带走的话：不要根据“抑制”或“激活”的字面情绪判断疗法，也不要疾病评价一个人的价值。

CHAPTER

第五章 指标、能力与意义：三种尺度不能互相吞掉

好的照护不只知道什么下降了，也知道什么被保存、什么变得可能。

一、为什么需要不止一张成绩单

如果用一张成绩单评价健康，我们首先要问它遗漏了什么。风险指标、实际功能、症状与个人生活目标，关注的是不同方面。某项治疗可能使长期风险下降，却暂时增加执行负担；一次照护调整可能显著减少奔波，却不改变某个化验值。不能因为结果没有落在同一列，就认为其中一种不真实。真正的困难，是怎样在不同尺度之间说明关系，而不是选择一个最方便的尺度代表全部。

本书建议把评价至少分成三层：风险是否得到可靠管理，日常行动与恢复能力是否受到支持，当事人珍惜的生活是否更可持续。这是组织讨论的建议，并非一个已经验证的评分系统。它也不是说三层必须永远同幅度改善。某些疾病阶段以避免严重事件为优先，某些情境需要先解决不适或照护困难；关键是让取舍可见，并定期确认它是否仍然合适。

二、指标可以保护人，也可能被误用

对数字的批判很容易获得共鸣，因为每个人都可能有过被考核的经验。但不能把对考核方式的不满，直接移到数字所承载的医学信息上。血压、血脂或血糖的测量，有各自的技术规范、证据基础与解释范围。它们不是无所不能，也不是任意虚构。[1—9] 需要纠正的是“只要达标就完成了照护”的推论，而不是废除测量本身。

一个被误用的好指标，仍可能是好指标。比如，团队把某项达标率作为工作线索，本来可以帮助发现未获充分治疗的人；若后来只奖励达标而不问测量质量、个体耐受和失访原因，指标就可能变成遮蔽复杂性的工具。这里的问题在于制度怎样使用它。若换成一个更含混的“意义指数”继续同样考核，旧问题不仅没有消失，还可能因无法核实而更难纠正。

三、能力不是永远摆脱依赖

原稿强调调节能力，是为了把健康从被动接受扩展到参与形成。这一方向值得保留，但能力不能被定义成“所有事情都由自己完成”。现实中的能力常常由可靠支持共同构成：有人帮助读懂处方，有人改善交通条件，某种治疗使症状减轻，适当的器具使活动更安全。评价能力，应当看一个人在这些条件中能否行动，而不是检查他是否彻底不再依赖任何外物。

这也改变了对成功的理解。一个人需要长期治疗，却更知道何时求助、如何记录、怎样安排活动，并能参与自己的决定，可以被视为照护取得进展。相反，一个人为了证明自主而停止必要治疗，即使暂时感到轻松，也不能据此宣布自由律已经恢复。真正的能力包括识别边界、使用支持和承担修正，而不是用独立的形象掩盖危险。

四、意义不能成为另一项强制任务

当我们说生活需要意义，容易不经意地给患者增加新作业：每天必须快乐，必须感恩，必须找到使命，必须把疾病变成成长机会。这样的要求可能比原来的指标更苛刻，因为它不仅考核身体，还开始考核一个人怎样感受痛苦。幸福律若被这样使用，就会背离它原本要保护的主体。

意义可以很小，也可以暂时说不出来。它可能是安稳地吃一顿饭，能够自己洗澡，或者不再因为复诊安排而总向同事道歉。患者可以不愿把生病解释成礼物，也可以在某段时间里只是希望少受一点苦。尊重这些表达，并不妨碍认真治疗。照护的任务不是让每个人给出高昂的生命宣言，而是让值得他的那一点生活，不被程序轻易挤走。

五、一个可以带进诊室的共同问题

设想一个家庭会议的教学情境。家人希望父亲尽可能降低未来风险，父亲希望减少每天围绕健康展开的争吵，医生希望方案既有证据又能执行。如果大家只争“谁更关心健康”，讨论很快会变成道德比较。若改问“哪些风险必须处理，哪一种安排最难坚持，有没有更可行的选择，何时一起复评”，三种尺度就开始进入同一张桌子。

[20]

第一编到此形成一个基本立场：指标、能力与意义不是竞争谁能成为健康的唯一定义，而是共同约束照护。指标提醒我们不要被舒适感蒙蔽，能力提醒我们不要把要求当成已经发生的行动，意义提醒我们不要忘记保护的目的地。接下来必须处理一个更困难的问题：当这些方面发生冲突时，我们凭什么判断？第二编从因果与证据开始，使整体关怀不再依赖未经核实的确信。

带走的话：不要用一张化验单定义生活，也不要用一个意义口号取代化验单。

PART

第二编 从“翻案”走向可以检验的因果

原稿最有冲击力的表达，是把“三高”从罪魁重新解释为信号。但信号与原因并不总是互斥。本编保留对上游条件的追问，同时修正一个关键跳跃：发现某种异常怎样形成，并不意味着可以忽略这种异常继续造成的损害。

CHAPTER

第六章 信号也会伤人

找到一个结果的上游原因，不会使这个结果失去下游作用。

一、火警与火，为什么不是万能比喻

原稿多次使用火灾比喻：血脂、血压与血糖好像报警器，药物降低指标好像关掉警铃，而真正的火仍然在烧。这个比喻有一个合理提醒：不要只处理看得见的表现，而不追问形成它的条件。然而，它偷偷加入了另一个前提——报警器本身不参与火势。把这一前提移到所有生理变量上，就会产生错误。某个变量完全可能既反映上游失衡，又继续影响组织和器官。

更适合本书的教学比喻，是一间因进水过多而积水的地下室。水位升高提示入口或排水系统出了问题，同时，水本身也可能继续浸坏设备。寻找漏点与降低水位可以同时必要。这个比喻同样不是生理机制证明，但它至少不再强迫我们在“信号”和“伤害因素”之间二选一。医学中的因果链，往往允许一个环节同时有这两种位置。

二、“不是唯一原因”不等于“不是原因”

高血压、致动脉粥样硬化脂蛋白暴露以及持续高血糖，各有不同的机制与证据基础；它们不能被简单当成只有提示作用的中性读数。^[1—9] 但承认这些因素有作用，也不意味着认为它们是所有事件的唯一原因。心脑血管疾病可以涉及多个危险因素、既往累积损伤和不同事件机制。一个因素并非唯一，不会使其作用自动归零。

日常推理常把原因误想成一把唯一的钥匙：有它必然开门，没有它绝不可能开门。真实疾病风险通常不这样工作。一个因素可以增加某种结果的可能性，却不是充分条件；另一些路径也可能通向同一结果，使它不是必要条件。只有在预先声称某个因素既充分又必要时，一个不符合的个案才直接构成反例。否则，我们需要比较风险的变化，而不是只寻找一个没有按想象发生的人。

三、正常读数为什么不能抹掉过去

设想一个纯教学例子：两个人今天的某项指标相同，其中一人长期维持在适宜范围，另一人此前多年暴露较高，最近才通过治疗改善。不能只凭今天这一点，就认为两人所有既往影响和未来风险都相同。当前显露有自己的时间背景；正是这一点，使发生学视角与累积暴露、病程和长期随访等医学概念可以展开对话，而不是必须互相否定。

同样，一个人在急性事件发生时血压正常或偏低，并不能据此否定既往高血压的影响。事件本身可能改变当下状态，而此前的过程不会被一张急诊读数自动擦掉。判断时必须问“什么时候测量，测量前已经发生了什么”。SDE所谓差异序列，在这里可以成为一个有用的阅读纪律：不要把先后次序压缩成同一张静态照片，再让照片替整段历史作证。

四、反馈让“因”和“果”需要注明位置

在一个反馈系统中，某个变化可能是前一阶段的结果，又成为后一阶段的条件。我们可以用一个抽象模型帮助理解：条件A影响状态B，B又影响过程C，C反过来维持A。这个模型本身不说明具体疾病，却说明为什么“它只是结果”的说法不够。若B处在可干预的反馈环节，对B的有效干预可能改变后续过程，即使没有同时消除所有上游因素。

这并不意味着任何改变B的方法都有效。还需要知道干预怎样作用，有什么副作用，是否改善重要结局，以及在哪些人群中成立。由此形成两道独立的问题：第一，变量在因果网络中有什么作用；第二，某一种干预是否值得使用。前者不能仅凭药物名字回答，后者也不能只凭对变量的哲学解释决定。本书将这两道问题分开，正是为了使批判不再依赖概念滑移。

五、“翻案”真正值得保留的部分

如果“翻案”意味着宣布三高无害，本书不能保留；如果它意味着把被遮蔽的生活条件、病程与反馈重新带入讨论，它仍有价值。我们需要同时问：怎样减少已经存在的风险，怎样改善维持风险的条件，怎样支持患者长期参与。三个问题没有谁天然更高贵，也不必按“先全部治本再处理指标”的顺序等待。

对一个真实的人来说，可靠的保护与条件改变可以并行。遗传因素、既有器官损伤或难以迅速改变的工作环境，也使所谓“彻底消除根源”不总是现实。面对这些限制，干预可改变的环节并非不够高级，而可能正是负责任的选择。发生学的雄心，应当用来增加可理解和可行动的联系，而不是要求所有治疗先完成一个无法保证的总体改造。

带走的话：既追问风险怎样形成，也处理风险已经能够造成的损害。

CHAPTER

第七章 正常不是同一种线

参考范围、诊断门槛、风险变化与治疗目标，是四件有关却不同的事。

一、一张报告单上的箭头意味着什么

看到报告单上的箭头，读者很容易把它理解为身体越过了一道统一的好坏边界。但不同指标的参考区间、不同疾病的诊断标准以及针对个人制定的治疗目标，并不是同一种线。参考区间通常与特定检测方法和参考人群有关；诊断门槛服务于疾病识别与临床决策；风险可以随暴露连续变化；治疗目标还要结合获益、风险和个人条件。把四者混成一条线，既容易制造不必要的恐惧，也容易造成错误安心。

因此，“在参考范围内”不应被自动翻译为没有任何相关风险，“稍微超出参考范围”也不应被自动翻译为立即需要同一种治疗。具体含义需要放回指标、测量条件、既往病史与专业判断。原稿对数字的批评，有一部分其实应当指向这种翻译错误，而不是指向所有量化知识本身。准确区分数字正在做什么，比笼统宣告数字不能代表生命更有帮助。

二、连续的风险，为什么仍然需要门槛

疾病风险常常不是走到某个数值才突然从零变成一百。可是现实中的行动需要决策：什么时候进一步检查，什么时候复诊，什么时候开始某种干预。门槛的作用，是在连续风险与有限资源之间形成可讨论的行动规则。它不是说自然界在那个小数点上画了一道墙，也不是说门槛可以任意决定。

一个门槛需要有证据和权衡，可以随着研究、风险模型与公共卫生条件改变而修订。不同指南的定义或建议可能不同。例如，中国2024年高血压指南保留诊室血压140/90 mmHg的诊断界值，美国2025年指南采用不同的分级框架；这并不允许读者任挑一个数字给自己停药，而是要求临床解释所采用的规范、测量方式及个人目标。[1][2] 差异需要被说明，而不是被当作“所有标准都是骗局”的证据。

三、个体化不是给每个人编造一个私人常数

原稿曾根据年龄、体型或性格，为较高血压赋予“个体需要”的解释。这种推理过快。个体化要求结合可靠信息调整判断，并不意味着可以仅凭一个人高大、内向、情绪丰富或自觉精力充沛，就宣布某个长期偏高读数对他安全。没有相应证据的私人阈值，可能比明确的公共规则更难被纠正。

真正的个体化还包含如何测量、如何确认、怎样监测耐受、如何处理合并情况以及怎样复评。对于某些高龄、衰弱或多病共存的人，目标和实施方式需要尤其细致地讨论；但这不等于“老年人一律应该高一些”，更不等于头晕出现后就自行停止治疗。[1][2][25] 个体化增加的是判断的条件，不是减少判断的责任。

四、数字焦虑怎样形成

设想一个教学人物林阿姨，她每天反复测量，看到一次读数稍高就紧张，再测一次仍不满意，于是继续测，最后整个上午都围绕仪器展开。问题不只是仪器，而是她不知道测量为什么做、什么时候做、怎样记录、哪些变化需要联系医生。没有解释的监测，会使信息变成不断催促人的警报。

解决这个问题，并不必然是取消监测。更好的方向，是由专业人员帮助明确一套有目的、可负担的测量与反馈安排：使用适合且经过验证的设备，按规范获得读数，记录需要的信息，并事先约定什么情况需要行动。[1][2] 当一次测量有了位置，它不再要求患者马上替自己完成所有医学判断。工具的边界越清楚，患者越有可能从工具旁边回到生活中去。

五、让标准承担它能够承担的工作

标准可以减少随意性、帮助交流和保护那些不容易表达的人；标准也可能被僵硬执行。批判的目标应当是让标准说明自己的依据与局限，而不是把公共证据拆散成各自相信的故事。一个没有共同语言的医疗世界，不一定更尊重个体，反而可能使患者更难比较不同说法，更容易被最有把握的声音支配。

本书因此保留四种尺度的区分：报告在描述什么，诊断在界定什么，风险在提示什么，治疗目标在争取什么。每遇到一个数字，先问它属于哪一种。这个问题很朴素，却能防止许多宏大误解。正常不是一个可以包办生活的词，也不是一个可以轻易丢弃的词；它需要在具体语境中被解释。

带走的话：问清楚这是哪一种线，比争论要不要所有的线更重要。

CHAPTER

第八章 故事、机制与试验，各自能证明什么

一个令人难忘的故事，可以提出好问题；它还不能独自回答所有问题。

一、为什么个案总让人信服

“我的邻居一直吃药，后来还是心梗了。”这样的故事有姓名、面孔和记忆，比一张研究表格更容易进入我们的判断。但故事缺少一个不能直接看见的对照：同一个人若没有接受这项治疗，会怎样？我们无法让同一段人生同时发生两次，因此需要借助比较、设计与统计去估计可能的差异。故事不是没有价值，而是它更适合提示遗漏、提出假设和呈现体验。

相反，“某人改变生活后指标改善”，也不能直接证明某个新框架具有特异疗效。同期药物调整、测量方式、自然波动、回归均值、选择进入故事的人群，乃至没有被报道的失败，都可能影响判断。把一个成功故事讲清楚值得做，但应当如实说明它能够支持到哪里。原稿中没有病历与研究资料支持的疗效个案，本版不再作为实际结果刊载。

二、机制合理，为什么仍然可能无效

机制解释让人感觉已经看见因果的内部。某种做法能够改变一个通路，于是我们期待它改善疾病。然而，从通路改变到患者重要结局，中间可能有补偿、相反作用、剂量问题、时间问题或不可接受的副作用。一个局部机制可以真实存在，而整体干预仍然不值得使用。正因为如此，临床研究不能只停在“说得通”。

这也约束三律分析。即使我们认为某项活动可能增加选择感或改善执行条件，也不能立即宣称它会降低心梗发生率。前者可以是需要测量的中间变化，后者是另外的结局。将来开展研究，应当预先说明期待改变什么，观察多久，用什么工具，以及什么结果会使我们认为设想没有得到支持。理论越有雄心，越需要这种分层，而不是越可以跳过它。

三、比较需要把分母与时间一起带来

下面是纯粹用于解释的虚构数字，不对应任何真实试验。假设两个可比较群体各有一千人，在同样一段时间内，一组发生事件一百人，另一组八十人。可以说相对减少两成，也可以说绝对减少二十人，即两个百分点。两种说法都可能算得正确，但给人的印象不同。若不说明基线风险、人数与时间，只保留最醒目的百分比，读者就可能高估或低估实际意义。

同样，“仍然有八十人发生事件”并不证明干预没有作用；它提醒我们，风险没有被全部消除。至于这样的差异是否可信、是否值得，需要继续看随机分配、失访、置信区间、不良事件和研究适用人群。一个合格的阅读过程，不是找到一句支持自己观点的话就停下，而是把影响解释的条件一起带走。

四、两项试验为什么不能被剪成同一个口号

SPRINT与ACCORD常被放进“数字控制到底好不好”的争论。SPRINT在特定高风险、无糖尿病的研究人群中比较不同收缩压目标，报告了重要获益，同时也提示一些不良事件需要关注；ACCORD的强化降糖部分则在另一类高风险2型糖尿病人群中，发现追求更接近正常的糖化血红蛋白目标并未产生预期的整体好处，且出现死亡风险增加。[7][8] 它们的问题、对象、干预和结局不同，不能用一个结果给所有指标和所有治疗判决。

严谨的结论应该保留这些差异：某个目标在某些人群、某种实施条件下可能合适，在另一些条件下则不合适。这样的结论没有“整个现代医学被推翻”醒目，却更能帮助现实决策。整体观如果尊重差异，就应当首先尊重研究之间的差异，而不是把它们压成证明某个宏大立场的一张图。

五、参考文献不能只是权威的装饰

原稿某些段落在声称LDL没有因果作用的同时，列入了题目明确支持其因果作用的共识文献。这提示一个普遍的编辑风险：文献真实存在，不等于它支持正文；题目相关，也不等于研究结论相同。引用必须说明究竟借用了哪一项事实、推论的范围是什么，以及有没有与自己观点不一致的部分。[4]

本版重建参考资料，正是为了改变这种做法。不能核实的数据不保留为实证，示例性文献不伪装成已经完成的检索，教学案例不使用真实病例的口吻。读者也可以用同样标准检查本书：它是否如实呈现不利于自己的证据，是否把假设标明为假设，是否允许你沿着引用找到不同意见？没有这些条件，所谓知识重建就可能只是把旧的确信换了一套术语。

带走的话：读一个结论时，把它的对象、比较、时间、分母和限制一起读进去。

CHAPTER

第九章 代偿、适应与损害的边界

身体会应对困难，并不意味着每一种应对都适合长期维持。

一、“这是身体需要的”为什么还不够

当某种变化具有应对环境的作用，人们容易把它理解为身体自己的智慧，于是认为外部干预必然违背自然。但应对有时间尺度和代价。短期有帮助的反应，未必适合长期保持；在一种情境中保护某项功能的变化，也可能在另一种情境中增加负担。仅仅指出一项变化有代偿背景，还不能决定应该保留还是干预。

因此，本书把代偿看成需要进一步分析的过程，而不是免于治疗的通行证。我们需要问，它在应对什么，持续多久，是否仍在发挥原有作用，付出的代价是什么，以及有没有更安全的替代安排。对具体疾病，这些问题必须依靠专业评估与证据回答，不能凭“身体不会无缘无故这样做”就完成判断。自然发生，并不等于值得维持。

二、可变性不是越大越健康

原稿重视差异与节律，这是发生学视角的重要部分。但差异不是越大越好，波动也不是越剧烈越有生命力。适当的响应与恢复，和病理性不稳定，并不是同一件事。把“身体能够变化”误解为“应该主动制造更大的血压、心率或血糖波动”，会把一个哲学提醒推成危险的训练想象。

一个抽象系统是否运行良好，不能只看变化幅度，还要看变化是否与任务相称、能否恢复、是否超出承受范围，以及有没有造成损害。对身体而言，具体边界还取决于疾病状态和专业判断。本书因此不提供通过冷热冲击、突然憋气、极端禁食或剧烈运动来检验“调节自由”的做法。真正的自由，不需要通过让身体遭遇未经评估的挑战来证明。

三、恢复不是回到一条笔直的线

另一方面，安全也不等于消灭所有自然起伏。测量与治疗需要区分正常活动中的变化、测量误差与持续异常。长期作用的治疗并不意味着把身体锁死在一条不变曲线上，也不能仅凭一天内读数相近，就认定生命节律已经被药物抹去。相关判断需要规范记录和必要监测，而不是从曲线看起来“平”或“不平”直接推导。[1][2]

发生学可以增加一个有价值的问题：一次活动之后，恢复过程如何发生？但这个问题首先是研究与观察方向，不是要求每个患者每天自行进行负荷试验。对一些人，普通日常活动已足以提供需要沟通的信息；对另一些人，适合的运动评估应在专业环境中完成。把所有人都变成自己身体的实验员，并不比把所有人都变成指标的执行者更人本。

四、支持能力与训练能力，不是同一种动作

训练可以帮助某些能力形成，但不是所有功能不足都适合通过增加负荷解决。有时需要治疗疾病，有时需要减少负担，有时需要辅助工具或长期替代。若把“用进废退”机械应用到每条分子通路，就会误以为只要外部支持存在，内部系统一定变懒。这个推论既忽略了疾病本身，也忽略了支持可能带来的保护。

教学上可以把它理解为两个问题：怎样使当前处境安全，怎样增加未来可以做到的事情。前者不总是训练，后者也不总是减少支持。对于有些患者，稳定的医疗支持正是参加康复、学习和日常生活的前提。我们应当比较整个行动结构，而不是把“自己完成”预设为唯一好结果。需要帮助，并不是自由失败的证据。

五、把“激发”改写成有边界的动词

“激发身体潜能”是一句容易受到欢迎的话，但若不能说明激发什么、通过什么方法、适用于谁、怎样停止，就很难承担实践责任。本书保留生成与能力的语言，同时要求它们落到可核查的动作上。不是泛泛“重启系统”，而是确认一个安全且可持续的活动安排；不是宣布“恢复幸福通路”，而是了解一个人需要怎样的休息、支持或专业帮助。

这样的改写也许少了一点神奇感，却使失败能够被看见。一个行动没有帮助，并不意味着患者缺少信念；一种安排带来不适，并不意味着他还没有忍耐到“释放”。方案需要允许调整，理论需要允许被修正。发生学不只是赞美生成，也必须能够解释何时不应继续生成某种负担。

带走的话：能变化、会恢复、守边界，不能简化成让波动更大或让支持更少。

CHAPTER

第十章 协同不是把更多项目装进生活

整体照护的质量，不由项目多少决定，而由它们能否共同服务同一个人决定。

一、从单一方案到治疗拼盘的陷阱

当人们认识到只看一项指标不够，容易转向另一端：饮食、运动、睡眠、心理、营养补充、设备监测、情绪日记和各种课程全部加上去。每一个项目单独看似有理由，放到一起却可能占满患者的一天。这样的“整体”只是数量相加，没有处理时间、费用、体力和注意力之间的冲突。

本书所谓协同，首先意味着安排之间能够互相解释。一个人最需要处理的风险是什么，当前最妨碍执行的困难是什么，哪一项支持可能同时改善多个环节，哪些项目可以暂缓或省去？多病共存的照护尤其需要关注治疗负担与个人目标，而不是把各疾病指南的任务逐项堆叠。[25] 整体观不应使患者拥有更多无法完成的作业。

二、结构重建可以从一个具体障碍开始

设想一个教学情境：陈女士知道自己需要规律复诊，却总是缺席。若先判断她“不重视健康”，解决办法可能只是加强教育；若追问过程，才发现复诊时间与她照顾家人的安排持续冲突。此时，知识并不是唯一缺口。需要讨论的可能是预约、交通、照护接替以及如何在适当情况下获得连续支持。

这个例子说明，结构并不一定是宏大制度，也可以是一段日程里的连接方式。重新安排一个环节，可能使原本无法执行的计划成为可能。但这里仍不能直接宣称某种组织调整必定改善临床结局。我们可以提出合理的作用路径，再观察是否真实发生。结构重建的严谨性，就在于把“看起来可能”与“已经得到支持”分开。

三、不同干预需要同一种证据纪律

药物、手术、生活方式支持、心理干预、传统疗法和数字工具，都应当根据具体方法、适用条件、收益与风险评价。不能因为某种方法被称为自然、整体或激活，就免去证据要求；也不能因为某种治疗属于现代技术，就假定它必然忽略人。分类名称不能代替对实际方案的判断。

这也适用于本书自己的框架。若三律支持计划包含已经有依据的常规照护内容，应当说明这些内容原有的证据；若还提出了新的组织方式，则需要独立检验新增部分的价值。把所有改善都归功于新术语，会掩盖真正起作用的环节。对于患者来说，重要的不是某个体系赢得了名称上的胜利，而是哪些具体帮助值得保留。

四、怎样把协同写成一项可修正的决定

一个可用的决定，至少需要说明当下的目标、行动的责任人、执行条件、观察内容和复评时间。这里不要求复杂表格。例如，患者可以与团队确认：“当前先处理哪项风险；我遇到的主要困难是什么；这段时间按什么安排执行；出现哪些情况联系谁；下一次讨论根据什么调整。”这些问题使共同决策从态度变成过程。[20]

与此相比，“全面改善生活方式”过于宽泛，“一个月重启三律”则缺少可核实的含义。好的计划可以不宏大，但不能没有反馈。它应当容纳未完成和不适，允许患者指出某项安排实际上不可行，也允许专业人员解释为什么某些保护不能轻易取消。协同不是意见永远一致，而是分歧仍有被处理的位置。

五、进入血脂、血压和血糖之前

第二编完成了一次必要的转向：不再让“信号而非原因”“自然而非药物”“整体而非数字”这样的二分法主导全书。我们将风险、过程与意义放在一起，但不让其中任何一项替另一项作证。一个事件有多个原因，不代表任何原因都可以忽略；一种治疗不完美，不代表没有作用；一种理论能组织问题，不代表已经验证疗效。

接下来的三编，将把这些纪律放到更具体的健康问题中。读者会看到，血脂有生理角色，也有需要管理的暴露风险；血压有情境与节律，也有不能被个性化语言取消的危险；血糖连接能量、药物与生活，却不能由快乐或自由的比喻决定治疗。真正的重建，不是把复杂事实改写成更容易相信的故事，而是让故事承受复杂事实。

带走的话：整体不是加法；它是把风险、条件、行动与反馈组织成可持续的关系。

PART

第三编 血脂与血管：越过敌人的隐喻

原稿希望替被妖魔化的血脂恢复生理身份。这个愿望可以保留，但“有生理用途”与“长期过多暴露无害”并不是同一个命题。本编不寻找一个可以替所有问题背锅的敌人，也不为了整体观而撤销已经得到支持的风险。我们讨论的是：物质、血管壁、时间、治疗与生活条件，怎样共同进入判断。

CHAPTER

第十一章 LDL不需要被妖魔化，也不能被免责

一种物质有用，不等于它在任何位置、任何水平和任何时长下都安全。

一、身体需要胆固醇，不等于需要任意高的血中LDL

读到“坏胆固醇”这个俗称，普通读者容易想象身体里混进了一种本来就不该存在的毒物。这样的说法确实过于粗糙。胆固醇有生理用途，脂蛋白参与脂质运输；理解这些角色，可以帮助我们摆脱把身体分成好物质与坏物质的道德图景。然而，血液中某类脂蛋白的暴露水平，与每一个细胞是否拥有正常结构，并不是同一个问题。降低适当人群的血中LDL，也不意味着把全身所有胆固醇清空。[3—5]

原稿的跳跃发生在这里：先指出胆固醇有用，然后要求读者接受“因此降低LDL会破坏生命的基本意义”。前一句属于生理知识，后一句却需要关于具体干预和实际后果的证据。它们之间不能靠“有用的东西不可减少”搭桥。水有用，过多或位置不当也可以造成问题；这个日常类比只说明推理形式，不充当LDL的医学证明。LDL的具体判断，还要回到它自己的证据。

二、把角色、剂量与时间重新放在一起

在发生学语言中，一个变量的意义不由名字一次性决定。它处在什么关系里，持续多久，与哪些条件相互作用，都影响结果。由此看，累积暴露并不是发生学的敌人，反而是一种清楚的过程思想。今天的一次测量需要被放进过去与未来，短时间内没有症状，也不能自动说明长期暴露没有后果。

遗传、流行病学与干预研究从不同方向支持LDL参与动脉粥样硬化性心血管疾病的因果作用。[4] 这并不意味着每一位LDL较高者都会在同一时间发病，也不意味着所有心血管事件只由LDL造成。它说明的是：在相应条件下，减少这项暴露可以成为降低风险的有效途径。承认不确定性与个体差异，不等于把总体证据撤销。

三、幸存的故事不能独自替长期风险作证

“有位老人血脂高，活到了九十岁。”这样的故事可以真实，也值得尊重，但它回答的是某一个人经历了什么，不是所有可比较人群会怎样。我们还需要知道没有活到九十岁的人、其他危险因素、既往治疗、测量时点，以及疾病是否反过来影响了当时的读数。只挑选站在终点的人来解释安全，很容易把未能出现在故事中的人漏掉。

反方向也一样。不能拿一位血脂正常却心梗的患者，证明所有降脂治疗无效。事件可以通过不同路径发生，当前读数也可能已受治疗影响。正常读数不是一张覆盖所有风险的保险单，这恰好说明预防需要多通道，而不是说明任何一条通道都没有价值。发生学若要关注过程，就不能只在个案有利于自己时关注过程。

四、风险分层不是给每个人同一场战争

本版不把“LDL有因果作用”改写成“每个人都应立即追求最低读数”。预防决策需要考虑已有疾病、整体风险、其他相关信息、可预期获益以及治疗负担。2026年血脂异常指南以更广的致动脉粥样硬化脂蛋白和整体风险为框架，也强调在适当情境下利用额外风险信息帮助判断。[3] 这不是任意追低，也不是只看一个箭头决定全部治疗。

对普通读者而言，可以带进诊室的问题不是“LDL到底是好还是坏”，而是“我的风险处于什么层次，这项治疗希望避免什么，为什么采用这个目标，有哪些负担需要监测”。这些问题不要求患者自己完成危险分层，却使他知道判断不是一句口号。专业知识与主体参与，可以在同一段解释中出现，而不必互相退场。

五、替LDL撤去道德审判，也替证据保留位置

本书愿意撤去“坏”这个词中不必要的妖魔化，却不撤去风险事实。我们不需要憎恨一种脂蛋白，才能合理管理它；也不需要把它宣布为完全无辜，才能反对只盯化验单的照护方式。把身体物质变成敌人或英雄，都容易遮住条件与程度。

特征律在这里要求看清具体暴露与个人处境，自由律要求保留有依据的选择和反馈路径，幸福律要求治疗不失去生活目的。三律没有哪一条要求我们拒绝降脂，也没有哪一条能够保证某种降脂安排一定合适。它们应当使讨论更细，而不是使结论更绝对。LDL不需要一场法庭式昭雪，患者需要的是一场可理解、可核实的决策。

带走的话：不要把脂蛋白当恶人，也不要把生理用途当免除风险的理由。

CHAPTER

第十二章 斑块不是水管里的油垢

理解血管壁怎样变化，比想象把血管冲洗干净更接近问题。

一、一幅过于方便的图画

把血管画成水管，把斑块画成管腔里的油垢，再画一股强水流把它冲走，是一种很有吸引力的健康叙事。它简单、可视、似乎立即指向行动：多冲一冲，管道就干净。原稿批评这种机械图景，却又在另一些段落中借助更强的剪切、冲击或波动来设想血管重建，实际上仍未离开同一幅图。

动脉粥样硬化并非一层可以靠剧烈活动直接刷掉的油脂。脂蛋白在血管壁中的滞留及其引发的复杂反应，涉及细胞、炎症和组织结构的变化。[5] 这个事实不要求普通读者掌握全部病理，却足以否定“让血流猛烈一些便能洗掉斑块”的处方想象。比喻一旦准备指导行动，就必须接受真实结构的约束。

二、结构变化为什么需要时间

一块斑块不是一天形成的，一个人的风险也不是一次测量产生的。治疗与生活安排改变之后，我们看到的结果可能出现在不同时间尺度上：某些指标较早改变，组织影像可能需要更久，重要临床事件则需要足够随访才能比较。不能要求所有层级同一天给出同样的答案，也不能因为某一层级改善，就保证其他层级已经完成恢复。

这正是发生学能够贡献耐心的地方。它使我们把“有没有用”展开为：首先可能改变什么，接着期待什么，哪些变化还未得到证明，何时应当重新判断。一个被时间展开的解释，比“斑块永远不能变”或“一个月全部清除”更诚实。它允许真实改善存在，同时不夸大改善的范围。

三、影像上的退缩不等于从此没有风险

GLAGOV研究在已经接受他汀治疗的冠心病患者中，比较加入依洛尤单抗与安慰剂后的冠状动脉影像变化，观察到了平均斑块负荷的差异。[15] 这使“任何药物都只能让数字变化、绝不可能影响斑块”这样的断言不能成立。但该研究的影像终点，也不能被反向夸大为“所有斑块都被清空”或“未来事件已经不再可能发生”。

影像、症状与临床结局各有价值。一个影像指标改善，可以支持某一结构层面的判断；治疗是否减少患者重要事件，则需要相应的结局研究。例如FOURIER研究观察了特定高风险人群的心血管事件，而不是只看影像。[16] 两类研究可以互相补充，但不能互相冒名。尊重层级差异，是整体论证的组成部分，不是整体观需要跨越的障碍。

四、剪切力不是越强越好的清洁剂

血流与血管壁之间的力学关系是研究对象，但这不允许我们把任何增加冲击的办法当作治疗。运动的方式、强度和进展，应当考虑个人疾病、功能与安全条件；已经患有心血管疾病或有不明症状的人，更不能用突然剧烈运动检验血管是否“恢复自由”。[28] 本版不保留冷热交替、憋气冲击、快速蹲起或高强度间歇“洗斑块”的建议。

一个有用的区别是：医学研究某种力怎样影响组织，与患者应该怎样运动，是两道不同的问题。即使某种机制在实验条件中存在，把它转成家庭练习还需要剂量、安全性、适用人群和临床结果的证据。把实验语言直接翻译成个人处方，往往绕过了最需要保护人的那一段工作。

五、重建应当指向可以持续的保护

如果不再期待冲洗，重建还剩下什么？它可以指向综合风险管理、适合的活动、可持续的饮食安排、戒烟支持、复诊与必要治疗，也可以指向使这些事情真正可行的生活条件。[3][19][28] 这里没有一个神奇动作，却有多多个可以被解释、被评估、被修正的环节。

对三律而言，血管不只是一个等待修理的对象，但它也不能被生活意义替代。人的自由需要健康条件支持，健康条件也需要真实的物质过程得到处理。愿意尊重血管壁的复杂结构，正是尊重这个人的一种方式。真正的整体观，不会为了讲一个容易行动的故事，就把器官重新简化成一根可以任意冲刷的管子。

带走的话：活动可以参与保护，不能被许诺为冲洗斑块的技术。

CHAPTER

第十三章 从他汀到组合策略：获益、负担与剩余风险

一种治疗有帮助，不意味着它没有代价；有代价，也不意味着帮助是假的。

一、药物不应该承担人格审判

原稿把他汀描述为切断胆固醇合成、削弱细胞身份的手段。这种描述把机制词语与价值判断混在了一起。药物影响某个生物过程，是需要理解的机制；这个影响在特定人群中是否值得，需要比较收益与不良后果。不能因为“抑制”听起来消极，就把所有抑制性治疗归为压迫，也不能因为某条通路有正常功能，就断言对它作任何调节都会摧毁生命。

随机试验及其汇总研究支持他汀降低适当人群的血管事件风险。[6] 这项判断并不要求我们忽略症状、费用或患者的疑问。恰恰相反，越是需要长期使用的方案，越应当把收益的目的、负担的识别和后续调整讲清楚。一个人不应被要求在相信药物与相信自己的体验之间选择阵营。

二、剩余风险不是治疗失败的同义词

设想一个教学情境：赵先生已患冠心病，治疗后仍然担心复发。他问：“既然还可能出问题，为什么要继续？”这个问题需要认真解释。预防通常改变概率，而不是提供绝对保证。减少一部分风险，仍可能很重要；但因为还有剩余风险，也需要继续处理其他因素，而不是让一项治疗承担全部任务。

另一个相反的误解是：“已经吃了药，所以其他安排都不重要。”这同样把一个环节当作全体。生活条件、吸烟、其他疾病与治疗执行都可能影响整体管理。三律在这里最有用的不是宣布药物无效，而是追问它怎样与其他行动接通。孤立地增加一种药，与把它纳入一个理解清楚、可持续的方案，不是同一件事。

三、组合不等于越多越保险

在部分患者中，医生可能考虑他汀之外的降脂治疗；选择取决于风险、目标、耐受、可及性及具体证据。[3]这不是一份供所有读者照抄的阶梯表。药物名称再多，也不能代替对为什么增加、预计获得什么、需要监测什么的说明。组合策略的合理性不来自药物数量，而来自各项措施是否针对尚未解决的问题。

FOURIER在已经接受他汀的动脉粥样硬化性心血管病患者中，发现加用依洛尤单抗降低了相应复合心血管终点风险。[16]这个结果支持特定决策，却不允许推出所有低风险人都应采用同样方案，也不等于保证每个人寿命必然延长。适用人群与随访时间，必须与药物名字一起被带入解释。把研究边界保留下来，不会削弱证据，反而防止证据被过度销售。

四、肌肉不适既不能被轻视，也不能自动归因

患者在用药期间出现肌肉疼痛或无力，需要得到认真回应。2022年关于他汀与肌肉症状的个体数据汇总分析，提示他汀可以造成小幅额外风险，但治疗期间报告的多数肌肉症状并不能归因于他汀本身。[26]这不是说患者感觉是假的，而是说真实症状与具体原因之间仍需要判断。

合理的讨论应当核对症状出现的时间、严重程度、其他可能因素和必要检查，由专业人员决定是否需要继续观察、调整或更换方案。若只是告诉患者“研究说大多数不是药物，所以你不用管”，便错用了总体证据；若让他凭一次不适自行放弃所有风险保护，同样不妥。证据帮助我们不仓促归因，倾听帮助我们不漏掉真实问题，两者应当协同。

五、让长期治疗成为可以理解的支持

长期使用一种治疗，容易被讲成身体已经失败、只能依赖外物。本书拒绝这种人格化叙事。一个人是否自主，不由药盒数量直接决定，而与他是否被告知、是否能提问、是否获得必要支持、是否参与适合自己的决定有关。对一些人，持续治疗恰恰保存了更多行动机会。

因此，本章的结论不是必须吃或必须不吃某一种药，而是不要让药物替人生作审判。好的照护能够同时说清三件事：这项治疗为何值得考虑，它有哪些需要关注的代价，以及当情况改变时如何重新讨论。这样的支持不是把患者固定在一个不可更改的安排里，而是使他能够在可靠保护中继续生活。

带走的话：把获益、负担与调整条件讲清楚，比要求患者在“药物”与“自然”之间站队更重要。

CHAPTER

第十四章 心梗与脑卒中：不能等待解释完毕的边界

在急症面前，先让专业救治到达，再讨论事件的全部发生条件。

一、同一结局名称背后可能有不同路径

“心梗中风都是血管不通”，是一种方便却不够准确的归纳。脑卒中包括不同类型，处理也不相同；不同患者的心脑血管风险又可能涉及不同疾病与背景。[23][24] 如果先接受一个统一的三律病因，再用同一套练习或药物处理所有突然症状，就可能错过必须及时区分的问题。

整体观在这里应该增加分辨力，而不是使疾病名称失去作用。需要认识一个人的生活，不意味着可以跳过急性事件的识别；需要追问长期形成过程，也不意味着当下危险必须等到所有上游条件都弄清楚才处理。一个能够分清优先次序的框架，比一个声称所有层面永远同样重要的框架更能保护人。

二、突然的症状不应先被解释成情绪

胸部压迫、挤压或不适，伴或不伴呼吸困难、冷汗、恶心，以及某些上身不适，都可能需要紧急评估。突然出现面部不对称、一侧肢体无力、言语异常，或其他突发神经系统症状，同样不能等待自行恢复后再说。[23] 本书不要求读者据此自行确诊，只要求不要先把它们归为焦虑、疲劳或“张力需要释放”。

出现疑似心梗或脑卒中的症状，应立即联系当地急救服务，遵从接线员和急救人员的指导。不要先做呼吸训练、散步、冷热刺激或所谓通路激活，也不要为了记录完整数据而耽误求助。理论可以在安全之后继续讨论，急救窗口不会为了理论让路。这个优先级，应当写在所有健康教育的边界上。

三、为什么不能把阿司匹林当作通用护身符

阿司匹林可能是某些患者治疗计划的一部分，但不是所有成年人都适合自行长期服用的预防药。是否使用，需要考虑已有疾病、具体获益与出血风险。[24] “别人吃了没事”不是自己的适应证，“能够抗血小板”也不等于任何血管事件发生时都可以先吃再等。

尤其在疑似脑卒中时，不能自行假定一定是血栓造成，因为某些卒中与出血有关。疑似心梗时也应先联系急救，是否需要阿司匹林听从接线员或专业人员指导，不要服药后等待看看是否好转。[24] 这段说明不是一份远程急救处方，而是取消一个容易耽误或误导行动的通用药物想象。

四、急救之后，生活重建才真正需要展开

当急性危险得到处理，发生学的问题并没有结束，反而进入另一段过程。患者怎样理解发生过的事情，怎样恢复活动，怎样与家人重新分配责任，怎样安排复诊和治疗，怎样处理恐惧与不确定性，都值得进入照护。不能把救治成功理解为此后只需要按时吃药，也不能为了强调心理重建，就降低长期保护的重要性。

这里的重建需要专业康复与个人目标之间的沟通，而不是把统一强度的运动表交给所有人。对于一位希望回到工作的患者，与一位最在意独立起居的患者，行动安排可能不同。差异并不意味着谁的目标更高级。三律要求目标被看见、路径被解释、变化被复评；具体医学边界仍由临床情况决定。

五、避免把事件变成患者的道德失败

发生心梗或脑卒中之后，患者可能反复问自己是不是做错了什么。家庭也容易把担心转成责备：“早叫你不要生气”“你就是没有控制好自己”。这种叙述把复杂风险压成个人意志问题，既不够准确，也可能阻碍求助。本书不能再用“幸福律崩塌”“意义通路关闭”给这种责备增加哲学外衣。

我们可以讨论可改变的条件，却不需要判定患者活得不够正确。预防不能保证所有事件都被避免，发生事件也不证明所有努力毫无意义。更有帮助的问题是，下一段生活需要哪些可靠保护，哪些困难过去没有被看见，以及谁能够参与改善。把羞耻转成协作，是本书愿意追求的重建，而不是把责任全部交给一个已经承受疾病的人。

带走的话：疑似急症先求救；事件之后重建条件，不给患者追加道德判决。

CHAPTER

第十五章 血管重建不靠冲洗

不是让人做得越多越好，而是让有依据的保护真正进入可持续的生活。

一、从任务表回到行动条件

设想一个教学情境：一位销售人员每天路上奔波，午餐时间不定，晚上回家很晚。他反复收到“规律作息、均衡饮食、坚持运动”的建议，也确实知道这些词的含义。问题在于，知道并没有自动产生时间、场所、可选择的食物和休息机会。若每次复诊都只把同样的建议再说一遍，健康教育就可能变成重复指出一个人已经知道自己做不到的事情。

发生学重建从这里开始：不是再给一句更漂亮的口号，而是找出行动怎样被阻断。哪一个环节最值得先改变，谁能提供支持，哪些要求可以简化，哪些风险不能等待？一个小而可靠的改变，可能比一张覆盖全部生活的理想清单更有意义。这里说的是行动组织原则，不是承诺任何单一改变都能逆转斑块。

二、活动是生活的一部分，不是惩罚身体

身体活动具有广泛健康价值，适当人群的运动安排可以成为心血管风险管理的一部分。^[28] 但它不应被理解为吃了某种食物之后必须偿还的债，也不应变成证明意志力的竞赛。对于有症状、既往心血管事件或其他限制的人，适合怎样活动、如何开始与进展，应结合专业建议，而不是照搬他人的训练强度。

三律式提问可以补上执行层面的内容：他愿意做什么，什么地点可达，天气不好时有什么替代，是否需要陪伴，怎样知道当前安排难以持续？这些问题不是把喜好放在安全之上，而是让安全范围内的选择更真实。一个永远不能执行的完美计划，很难比一个可靠执行且可逐步调整的方案更有帮助。

三、饮食不是把愉快从餐桌上撤走

讨论饮食时，最容易出现两种极端。一种把每一口都变成危险审查，使家庭聚餐失去轻松；另一种则以生活需要快乐为理由，拒绝任何结构调整。更合适的方向，是把总体饮食模式、可获得的食材、家庭分工和个人文化习惯放在一起，而不是仅寻找一种神奇食物或禁止一切令人愉快的东西。[19]

例如，一个家庭可以讨论怎样让日常安排更符合需要，而不把某位患病成员单独放在被监督的位置。谁采购、谁做饭、工作日有没有可行替代，这些问题往往比再背一串营养词更接近执行。发生学重建重视环境，但不把环境改善冒充特异疗效；它使已经有依据的健康方向，更有机会形成实际行动。

四、休息与支持不是“心情治百病”

睡眠、心理状态与社会支持值得关注，但不能因此把心血管疾病全部归结为情绪。心理健康与心血管健康的相互关系，可能通过行为、生理与社会路径发生。[29] 认真处理压力和心理困难，是照护的一部分；它不应成为拒绝必要诊治的理由，更不能转成“只要开心就无需治疗”。

同样，休息也不是给每个人规定同一种完美日程。有些人的限制来自夜班、照护、住房或经济压力。支持可能需要家庭协商、工作安排调整或专业服务，而不是要求他在已经拥挤的一天里再完成一套放松课程。幸福律在这里不增加快乐考核，而是询问：一个人的恢复机会，是否在现实中有地方发生？

五、把进展写成一段过程

本编最后建议一种朴素的记录方法：把目标、实际行动、遇到的困难、观察到的变化与下次要问的问题放在同一页。它不需要被叫作指数，也不需要每一天都充满数据。重要的是，哪些安排确实帮助了这个人，哪些只是增加负担，哪些结果尚不能判断，都可以被保留下来。

这张记录页不会告诉你斑块减少了多少，也不会取代血脂复查或临床评估。它只是让医学结果与生活过程重新见面。风险控制不再独自站在一边，生活也不再只能以反抗治疗的方式表达。越过敌人的隐喻之后，我们看到的不是一场无须治疗的和平，而是一项需要证据、支持与耐心共同完成的保护工程。

带走的话：不承诺洗净血管，把可靠保护组织进一个人真正能过的日子。

PART

第四编 血压：让风险与节律同时 进入诊室

血压最容易把本书带入两个极端：要么把一个读数当作全部身体，要么把所有升高都说成身体的合理求救。本编拒绝这两个极端。我们把形成条件、测量方式、治疗作用、实际不适和生活节律放在一起，既不取消风险，也不取消人的叙述。

CHAPTER

第十六章 血压怎样发生

血压有形成它的条件，也有需要认真对待的后果。

一、从一个读数看见一个系统

血压读数看起来只是两个数字，但它不是一个脱离身体运行的独立物体。心脏泵血、血管状态、体液与调节过程共同影响循环，活动、体位、测量情境等又影响我们当时看到的表现。理解这些关系，能够使“高血压”不再像贴在身体上的抽象标签；但也不能由此推断它没有独立的临床重要性。持续偏高可以增加心、脑、肾等方面的风险。[1][2][31]

SDE在这里提出三个不同的问题：现在看见了什么，之前怎样形成，哪些条件维持着它。它要求把读数与过程连起来，却不允许把过程当作免除风险的理由。一个指标可以由复杂条件产生，同时成为下一阶段的作用条件。忽略这种双重位置，才会使我们一会儿只剩下数字，一会儿又只剩下解释。

二、不是每一种升高都能归为紧张

情绪、睡眠和工作压力值得进入询问，但不能承包高血压的全部原因。遗传背景、年龄、生活方式、肾脏及内分泌相关问题、药物和其他因素，可能以不同方式参与。临床上还需要在适当情境下考虑继发性原因。[1][2] 这些可能性不能被“缺乏释放”一句话提前关闭。

设想一个教学情境：一位年轻人被反复告知自己只是工作太紧张。他后来因为生活安排改善而感到轻松，但规范测量仍然持续偏高。此时，继续要求他寻找更深的情绪原因，并不比只盯住数字更全面。真正的整体观要允许自己的第一种解释失败，并把尚未处理的医学问题交给合适的评估。生活叙述与病因判断，需要联系，也需要区分。

三、代偿的解释不能自动变成治疗结论

原稿把高血压描述为身体为维持供血而作出的代偿，进而认为降低血压会使重要器官失去支持。这种推论不能一概而论。某些具体病理情境确实需要特别谨慎地处理灌注与降压速度，但不能把这些情境扩展成所有慢性高血压都应当被保留的理由。临床上的目标、速度和监测，正是为了在收益与风险之间作具体判断。[1][2]

一个系统曾经因困难而采用某种应对方式，并不意味着长期维持该方式代价最小。发生学真正应该追问的是，怎样在当前条件下减少损害，又不制造新的危险。它不是让治疗先向“身体原有的安排”宣誓服从，而是让任何改变都说明依据、过程与反馈。这里没有抽象的“降下去就是错”，也没有“越快越低越好”。

四、遗传与环境不是互相推卸的两方

当人们强调生活重建，容易让有遗传易感或无法迅速改变环境的人感到自己注定失败。反过来，若把所有问题都归于遗传，又可能使可改变的条件被忽略。更合理的提问不是谁单独负责，而是哪些条件当前可以调整，哪些需要医疗支持，哪些限制必须在目标与安排中被承认。

这也保护了社会维度。一个夜班工人不能仅靠理解健康知识，就拥有正常白班；一个承担长期照护的人，也不能轻易把夜间中断从日程中删除。发生学所说的E，即特征纠缠，要求这些条件得到具体描述，而不是统统归为意志薄弱。承认困难并不等于取消管理，而是使管理不再建立在虚构的自由时间之上。

五、风险控制与条件改变可以并行

“先把生活全部改好，再决定是否治疗”，看起来重视根源，实际上可能让必要的保护无限等待。相反，“既然已经治疗，就不必再讨论条件”，又会使维持问题的环节长期被忽略。两种安排都把本可以并行的工作人为拆开。

本书建议在同一次讨论中确认两条线：哪些风险需要现在处理，哪些形成条件值得逐步改变。两条线由个人的临床情况和现实条件共同决定，不以是否最终停药作为唯一成功标准。有人经过调整能够减少某些负担，有人仍需要长期支持；二者都可能拥有更好的照护。血压怎样发生，是一个帮助行动的问题，不是一个替所有升高开脱的答案。

带走的话：不要把高血压只当数字，也不要把它只当身体合理的求救。

CHAPTER

第十七章 测量、曲线与被误读的个体

要尊重一个人的差异，先要知道差异来自身体、情境，还是测量本身。

一、测量不是未经加工的真相

同一个人在匆忙赶路之后、交谈时和规范休息后，可能获得不同读数。袖带、设备、姿势和操作也影响解释。^{[1][2]} 因此，特征律不能从任何一个偶然数字直接出发。我们首先需要可靠地获得信息，才知道哪些差异值得进一步判断。把测量误差当作个人特征，并不比忽略真实差异更尊重个体。

这里可以看见SDE的一条实际用途：显露不是脱离条件的最终宣判。一个读数要与产生它的条件同时进入记录。这样做不会让数字失去意义，反而使它更能承担临床工作。指标受到批判之后，不应被丢到一旁；它应当被放回一个解释更充分的位置。

二、诊室之外为什么可能需要更多信息

有些人的诊室读数与家庭或动态监测结果并不一致，临床上需要区分不同表现。是否采用家庭监测或动态血压监测，取决于具体问题；它们不是互相比赛谁最接近“真正的我”，而是提供不同情境中的信息。^{[1][31]} 任何一种工具都需要适当的设备、操作与解释。

原稿把全天曲线看作生命节律的直接肖像，这个方向有启发性，却仍然需要限制。曲线可以帮助提出问题，但不能仅凭外观判断某个人的自由或幸福。夜间表现、活动变化与药物安排之间的关系，需要由专业人员结合背景理解。对一个夜班者，记录中的白天与夜晚，还未必等同于实际清醒与睡眠时段。

三、更多数据也可能减少理解

设想一个教学情境：许先生买了几种设备，每天收集大量数字，却越来越不知道应该相信哪一组。他从一个读数的焦虑，走进了十条曲线的焦虑。问题不在于技术太先进，而在于每一项数据都没有清楚的用途，也没有明确的响应者。数据增加了，判断责任却全部留给他一个人。

一个可持续的监测安排，应先回答为什么测、怎样测、谁来解释、何时需要行动。并非所有能够收集的信息都应该长期收集，更不应把未经验证的可穿戴估计值当作自行调药的依据。^[2] 技术的边界可以减少负担；一个什么都显示却不说明可信程度的界面，可能制造新的依赖。

四、不要根据身高或性格编造私人正常值

原稿曾提出，高大的人、情绪敏感的人或长期特殊生活方式的人，也许需要更高血压维持自己的状态。这类说法可以构成研究假设，却不能直接成为个人的安全界值。身高、性格和自我感觉，不足以让一个持续偏高的读数自动获得医学豁免。

真正的个体化，是在可靠信息基础上考虑年龄、合并情况、功能状态、耐受和生活目标等因素，而不是为每一种差异创造未经检验的标准。它通常需要更多解释，而不是更少。患者有权追问目标为什么适合自己，医生也需要说明哪些差异确实改变决策，哪些尚不足以改变。这里的对话比“每个人都有自己的正常”更困难，却更负责。

五、把曲线还给一次明确的讨论

如果患者已经有记录，可以把最有意义的信息与问题整理在一起：哪些读数按规范获得，哪些时候出现不适，是否存在明显的执行困难，以及自己最希望在复诊时间问清什么。没有必要把所有曲线都变成精美报告，也不应只挑选最支持自己立场的一段。

这使记录获得了“回写”的意义。它不仅存储过去，也影响下一步：继续什么，核实什么，调整什么，什么暂时不能判断。若数据只用来证明患者听话或不听话，它就失去了这一功能。好的监测不是让人永远留在仪器前，而是让有限的信息帮助他更安全地离开仪器，继续生活。

带走的话：先把测量做可靠，再让曲线帮助讨论；不要让曲线替人下结论。

CHAPTER

第十八章 降压药作用于什么

对一条通路的调节，不等于对一个人主体性的取消。

一、从动词的情绪回到作用的事实

“阻断”“抑制”“排出”这些词，在日常语言里容易带出被剥夺的感觉。原稿将它们与自由律直接对立，使药物还没有进入具体证据讨论，就已经在修辞中败诉。但同样的动词可以指向不同的医学后果。某种异常活动受到调节，有时正是保护功能的条件；反过来，“激活”“增强”听起来积极，也可能在不合适的情境中增加危险。

本章不提供个人选药表，而是修正这种语言推理。理解药物，需要分别知道它主要影响什么，为什么适用于某类情况，有什么监测要求，以及如何与患者的其他条件协调。把机制翻译成“身体被接管”，不能代替这些问题，也可能使患者对本来有必要的保护产生不准确的恐惧。

二、相近的目的，并不意味着相同的机制

ACE抑制剂影响血管紧张素相关生成环节，ARB作用于相应受体，两者不能笼统描述为把整个调节系统从身体里删除。它们在适当情境中用于治疗高血压，也可能因其他疾病而被采用；具体使用及监测由临床情况决定。[32][33] 机制差异的重要性，在于帮助专业判断，而不是让患者独自决定哪一条通路应该被保留。

其他常用降压药也分别作用于不同环节。钙通道阻滞剂不能被说成让所有血管永久瘫痪，利尿剂不能被说成无差别抽空身体， β 受体阻滞剂也不是简单抹去所有生理反应。类别内部、适应证与个人条件都有差异。[1] 本版撤回这类绝对化描述，同时保留对不良反应和治疗负担的认真关注。

三、为什么长期支持不只是临时救场

原稿将药物的正当性限制在“临时守住边界”，认为一旦危险减轻，就应该把控制权全部交回身体。但慢性病的实际情况不总是这样。某些风险和病理条件长期存在，持续治疗可能是长期保护的一部分。当前读数改善，也可能正因为治疗正在发挥作用，而不是证明治疗已经不再需要。[2][31]

用“依赖”形容这种支持，容易混淆治疗需要与成瘾，也容易把持续用药描写成人格失败。本书更关心支持是否合适、可理解、可获得、可修正。只要这些问题得到认真处理，外部支持与主体参与并不矛盾。一个人在接受治疗的同时，仍然可以拥有对生活的主动性。

四、不良反应需要进入方案，不需要被两种立场利用

任何治疗都可能有不适用的情境或不良后果。患者出现咳嗽、头晕、水肿或其他新问题时，需要与专业人员沟通，判断是否相关以及怎样处理；不同药物的监测内容也不相同。[32][33] 不能因为某类治疗总体有效，就把具体不适排除在外。

同样，不能把所有不适都当作“抑制生命”的证据。若一种药不适合某个人，可能需要的是调整或替代，而不是拒绝全部血压管理。不同后续选择的意义，需要结合实际情况。三律在这里提醒我们：特征要具体，自由要包含有依据的替代，幸福要让负担可以被说出来；它没有授权一个抽象体系替临床处方作最后决定。

五、药物复评的结论不预先写好

一次充分的复评，可能得出继续、加强、简化、改变或在适当条件下减少某项治疗等不同结论。不能把“最后能够停药”预设为唯一正确答案，否则所谓复评只是向预定结局寻找理由。对于一些患者，原方案确有调整空间；对于另一些患者，维持必要治疗才是保护更多未来选择的方式。

本章希望读者带走一种更具体的问法：“这项治疗现在承担什么任务？我的哪些变化值得重新评估？接下来怎样知道方案仍然合适？”这些问题既不要求盲从，也不鼓励自行撤药。它们让药物回到支持的位置，而不是成为一种需要忠诚或反抗的权威象征。

带走的话：复评可以得出多种结论，不能预先把停药写成唯一成功。

CHAPTER

第十九章 头晕、疲惫与被遗漏的治疗负担

不适不是必须忍耐的噪声，也不是可以立即给治疗定罪的判决。

一、原稿提出的痛点应当被保留

原稿最值得认真对待的一种声音，是“数字变好了，我却没有变好”。这句话不应被一句安全声明压下去。一个人出现站立不稳、疲惫、活动减少或其他变化，可能直接影响他能否工作、出门和独立起居。如果照护只承认化验与读数，不承认这些后果，它就会失去与生活的联系。

但承认不适的重要性，不等于提前认定其原因。症状可能与疾病、其他病情、药物、睡眠、情绪或多种因素有关。某些情况需要及时就诊，不能仅靠一本书自我分析。真正的倾听不是立刻提供一个让人满意的归因，而是让这个问题不被遗漏，并进入足够认真的评估。

二、把模糊的不适展开为一段经过

设想一个教学情境：吴阿姨说，最近“总是发虚”。继续询问后，她描述主要发生在早晨起身之后，有时不得不扶住桌子。这样的细节，比“整体能量下降”更能帮助临床讨论。还需要了解何时开始、是否晕倒、是否同时改变治疗或进食、有没有其他伴随症状。这里不是让家人自行诊断，而是让患者的叙述获得可以回应的形态。

如果她近期反复跌倒，问题更不应被化约为“年纪大了”或“药吃久了当然如此”。多病共存和衰弱情境下，需要特别关注治疗负担与安全。^[25] 本书不提供自行停哪一种药的答案；它要求这类问题被摆到复评的前面，而不是等到下一张达标报告之后再处理。

三、过度治疗与治疗不足都可能伤人

讨论过度治疗很重要，但它不能让治疗不足消失。目标过于激进、方案不合适或缺少监测，可能造成问题；持续危险没有得到足够处理，也可能造成问题。二者不是一场只能支持一方的辩论。临床判断需要根据具体信息，找到收益与风险的关系，而不是依据“多就是不好、少就是自由”的原则。

SPRINT等研究提醒我们，强化目标可能在特定人群中带来获益，同时需要关注某些不良事件。[7] 这个同时性，正好要求我们把风险结局与患者负担共同记录。只报道收益，会使照护显得过于顺滑；只报道不良事件，又可能掩盖减少严重事件的价值。患者需要完整的权衡，不需要被选定的一半证据。

四、家庭的担心为什么会变成新的压力

家人往往希望保护患者，却可能把保护执行成频繁提醒、责备和监视。患者每一次表达不适，都被追问是不是又没有按要求做；每一次想外出，又被担心拦住。结果是，家庭的支持逐渐变成另一套指标管理系统。这样的关系需要讨论，但不能把责任简单推给“控制欲强的家人”，因为他们也可能缺少清楚的信息与求助路径。

一次共同解释可能帮助双方知道：哪些保护确有必要，哪些变化需要联系专业人员，哪些事情可以由患者自主安排，家人怎样参与才不是替他生活。是否让家人加入讨论，应尊重患者意愿。[20] 这不是增加一堂道德课，而是重新分配信息、责任与可行动的空间。

五、减少负担，不等于取消所有任务

有时，一项安排可以更简明；有时，需要把多个复诊协调起来；有时，某项治疗值得重新权衡；也有时，患者需要理解为什么暂时仍须承担某种负担。真正的人本不是保证每一次讨论都让任务减少，而是让负担具有理由、被看见，并可以随情况改变而重审。

在SDE语言中，负担不是孤立的数字，而是与行动序列和条件交织的结果。同样一项任务，对有支持的人可能可行，对独自照护家人的人可能成为最后一根稻草。理解这种差异，可以使照护更具体。它不取消医学目标，却要求目标在真实生活中拥有一个可执行的形态。

带走的话：既认真调查治疗负担，也认真保留必要保护；不让患者在两者之间独自选择。

CHAPTER

第二十章 个人节律不是统一的时刻表

节律需要被了解，不能凭一本书宣布所有人同一时间服药、睡眠或训练。

一、日程与身体并不总能整齐对齐

原稿强调晨起、白天活动和夜间恢复，意在反对把身体看作没有时间的机器。但人的工作与照护安排差异很大。夜班者可能在白天睡眠，照护者的休息可能反复中断，跨时区工作者的日程也可能不稳定。若把某一种日出而作的生活描写成唯一正确的节律，反而会让最需要支持的人被排除。

特征律要求先了解实际日程，自由律要求讨论可行替代，幸福律则提醒我们注意恢复机会是否真实存在。这里的重点不是让每个人达到同一张理想作息表，而是减少无法承受的冲突，并使必要治疗能够与生活协调。节律不是一项新的服从训练。

二、早上还是晚上服药，不能只靠直觉决定

原稿一方面强调夜间血压下降，另一方面又把夜间较高状态解释为恢复需要，进而建议撤去夜间治疗。这两套叙述之间存在矛盾，也都不足以成为普遍用药规则。TIME研究比较通常降压药晨间与晚间服用，在其研究人群中未发现主要心血管结局的显著差异。^[27] 2025年BedMed研究也没有显示把常规服药统一改到睡前可以改善其主要临床结局。^[34]

这些结果不是说时机对任何个人都完全无关，而是反对一刀切地宣布某个时刻普遍更好或更坏。具体安排还要考虑药物特点、实际睡眠、症状、执行便利及专业建议。读者不应因为本章而自行换时、漏服或撤药。真正的个体化，需要把问题交到可以负责调整的人手中。

三、夜班者需要的不是责备

设想一个教学情境：刘师傅轮班工作，白天补觉总被家人叫醒，晚班时又担心服药后上厕所不方便。他并不是不知道规律作息重要，而是日程里缺少能够共同遵守的安排。若只说“你必须早睡”，等于给出了一个与现实无关的目标；若因此宣布治疗无法执行、干脆不管，又让风险继续无人承担。

更有用的讨论，是把班次、休息时段、服药困难和复诊安排写到同一张纸上，由专业人员与本人共同寻找适合的执行方式，家人则在患者同意下帮助保护休息时间。这个例子不预设最后会改变哪一种药或哪个时刻。它展示的是，生活条件可以进入医疗讨论，而不必先被解释成个人自律不足。

四、恢复不能靠突然制造更大刺激

原稿某些训练建议把冷热刺激、迅速蹲起与强度运动视为重启血管自由的方法。本版不保留这些未经个体安全评估的方案。人并不是因为在理论上需要差异，就应该主动承受更剧烈的刺激；有病史或有不明症状的人，也不能用挑战身体来证明自己已经摆脱控制。

较稳妥的方向，是在适合的安全范围内建立能够持续的活动与休息安排，并根据反馈调整。^[28] 休息不需要被神秘化，活动也不需要被英雄化。一个能重复、能暂停、能获得支持的安排，比一次充满激情却缺少边界的“重启”更符合本书对自由的理解。

五、节律的意义在于关系，而不在钟表崇拜

第四编最终回到一个共同问题：怎样让可靠的风险管理与真实的日常时间共存？血压需要规范测量，也需要临床解释；治疗需要证据，也需要耐受与执行条件；节律需要被了解，却不能被一句自然法则包办。三者之间的协调，没有一个所有人通用的时刻表。

当一个患者能够说清自己的主要困难，知道哪些变化应当求助，能够参与调整，并在可靠保护中恢复一些可持续的生活，他的主体性就不只是一个抽象宣言。它是在具体关系中发生的。我们不必用放弃治疗来证明这种发生，也不必以放弃生活作为接受治疗的代价。

带走的话：把日程带进诊室，让专业判断与生活条件共同决定安排，不用停药证明自由。

PART

第五编 血糖：让代谢与生活共同持续

原稿把糖与自由放在一起，是想反对一种只许合格、不许生活的健康想象。这个问题值得保留，但不能因此把胰岛素、降糖治疗或所有饮食安排写成自由的敌人。本编讨论一个更困难的目标：让可靠的代谢管理与有尊严、有愉快、可持续的生活同时发生。

CHAPTER

第二十一章 胰岛素不是敌人

不要用一种身体物质解释全部疾病，也不要用来反抗它来证明人的自由。

一、一个过于好用的反派

当公众叙事从“糖是敌人”转向“胰岛素是敌人”，看起来发生了思想革命，推理形式却可能没有改变。原来由糖承担一切责任，现在换成胰岛素；原来期待彻底消灭某个指标，现在期待压低一个激素就找回自由。复杂系统再次被压缩成单一角色，而生活中的行动依然可能围绕一场战争展开。

胰岛素参与重要的代谢调节。不同类型糖尿病的形成与治疗并不相同，不能把所有患者都放进“胰岛素过多导致身体懒惰”的叙述。尤其对1型糖尿病患者，胰岛素治疗是维持生命所必需的支持，不能用情绪调整、禁食或所谓三律激活替代。^[9] 这一点不是本书理论之外的小注，而是理论进入实践之前必须遵守的边界。

二、抵抗与不足，需要在病程中理解

对于2型糖尿病，胰岛素抵抗与胰岛 β 细胞功能问题可以同时参与，病程和个人情况存在差异。^[9] 不能只看到“抵抗”二字，就把它解释为细胞在拒绝错误生活；也不能把需要胰岛素治疗理解为这个人已经失去自我调节资格。医学术语中的抵抗，是功能关系的描述，不是一个微型主体作出的道德抗议。

SDE可以帮助我们关注病程：现在的状态由哪些过程形成，哪些条件仍可改变，哪些需要持续支持。但它不能仅凭哲学关系决定某个人有多少胰岛功能，更不能算出该用多少药。三方程若要进入这种预测，需要完成变量定义与临床验证；在本书中，它们还承担的是组织问题的任务。

三、外源支持为什么可能增加行动空间

设想一个教学人物，一位年轻的1型糖尿病患者，她希望继续学习、旅行与运动。若把注射或设备解释为身体被接管，她就会在管理疾病之外，多承担一种不必要的羞耻。更合适的理解是，可靠治疗、教育、监测和适当支持共同形成了她行动的条件。主体性不在于完全不需要外物，而在于她能理解、参与并得到可以持续的帮助。

这并不意味着治疗没有负担。时间安排、费用、设备使用、对低血糖的担心，都可能进入生活。承认这些困难，是为了改善支持，而不是据此否定必要治疗。自由律要帮助她拥有更多安全可走的路径，不能要求她先拆掉保障生命的桥梁，再证明自己能独立过河。

四、“用进废退”不能包办内分泌判断

原稿常以肌肉训练为比喻，推断外部替代必然使内部系统退化。这种直觉不能机械应用到所有生理通路。是否需要减轻负担、补充缺乏、调节异常或进行某种训练，取决于疾病机制与具体证据。一个功能受损的系统，不会因为我们拒绝支持，就必然重新学会工作。

同样，暂时不需要某种药物，也不证明一个人的三律比别人完整。把治疗方式变成能力排名，会使疾病差异被道德化。更值得比较的是：这个人是否获得适合自己的照护，是否理解下一步，是否能够应对重要风险，是否拥有愿意继续的生活。这里的比较发生在个人的过程之中，而不是不同患者之间的优越感之中。

五、从反派叙事走向问题地图

本章建议把“胰岛素到底好不好”改成几道具体问题：我属于什么情况，目前治疗的目的是什么，生活安排有哪些需要协调的地方，哪些异常需要及时处理？这些问题可以带进专业讨论，却不要求读者自己制定方案。它们让胰岛素回到具体的生理与治疗关系，而不再扮演一种人格象征。

自由的真相，不是让身体永远拒绝外部帮助，而是让帮助不以取消主体为代价。对于需要胰岛素的人，这种自由可能发生在更清楚的解释、更可靠的供应、更合适的技术与更少的污名之中。发生学若要真正服务患者，应当参与建设这些条件，而不是给必要治疗制造一个哲学上的敌人身份。

带走的话：胰岛素不是人格失败的标记；需要它的人，不应因追求自由而失去必要支持。

CHAPTER

第二十二章 降糖药物图谱：从名称判断走向具体权衡

一张药物图谱的作用，是帮助提问，不是让一本书替每个人开处方。

一、同样叫降糖药，并不只改变同一件事

原稿对多类降糖药逐一作三律解构，这是整包材料的重要部分。本版保留逐项分析的结构，但改变判断规则：不再把影响代谢的任何作用都解释为对自由的破坏，而是先区分机制、适用情境与不良后果，再讨论治疗怎样进入生活。类别名称不能独自决定一种药适合谁，药物数量也不能直接代表治疗好坏。

现代选择还可能考虑心血管、心力衰竭、肾脏、体重、低血糖风险、费用和患者偏好等方面，而不只是追求同一幅糖化血红蛋白图。[9] 这不意味着每种新药都必然优于旧药，也不意味着所有人都需要最复杂的组合。真正的个体化需要把具体的收益与负担说清，而不是把“新”“自然”“激活”当作优先证据。

二、二甲双胍与促分泌药，不应被同一种比喻抹平

二甲双胍影响葡萄糖代谢，包括减少肝脏葡萄糖生成、改善胰岛素发挥作用的条件。胃肠道不适、肾功能等适用限制及长期使用中的维生素B12问题需要关注。[35] 这些内容足以支持认真监测与个体评估，却不支持“它必然关闭代谢身份”的说法。一个机制是否值得利用，不能只由其作用于肝脏这一事实决定。

磺脲类药物如格列齐特，通过促进胰岛素释放发挥降糖作用，低血糖等风险需要在使用中被认真考虑。[36] 这与二甲双胍不是同一套机制。原稿将促分泌概括成“榨干胰腺”，把一个需要具体证据与病程分析的问题提前变成结局。更合适的提问是，这类治疗为什么适合或不适合当前患者，怎样识别风险，生活中的进食与活动安排是否需要专业协调。

三、肠道与肠促胰素，不是愉快的开关

阿卡波糖延缓食物中部分碳水化合物的消化，常见胃肠道反应需要考虑；它不是阻止一切营养进入身体，也不能据此宣布餐桌上的愉快被药物取消。[38] DPP-4抑制剂如西格列汀则经肠促胰素相关路径帮助调节血糖，与直接阻止碳水化合物消化不是同一件事。[37] 将不同药物画成相同的“封闭通道”，会让图谱失去最重要的差异。

GLP-1受体激动剂等药物可以影响血糖、食欲和体重，具体品种与适应证各有证据及注意事项。[9] 食欲改变可能影响个人感受，这值得询问；但不能从作用机制直接推导出患者必然失去快乐、情感或生活意义。若出现持续不适或心理困扰，应当进入真实评估，而不是被预先安置在一种幸福律崩塌的解释中。

四、SGLT2抑制剂说明了为什么不能只看一个出口

SGLT2抑制剂通过影响肾脏对葡萄糖的重吸收，使更多葡萄糖从尿中排出。若只用“把糖倒掉”评价它，就很容易把这一机制描写成掩盖问题。但EMPA-REG OUTCOME和DAPA-HF等研究在不同、明确的人群中观察到了重要临床获益，包括相应心血管或心衰结局。[17][18] 这说明评价不能停留在一个机制比喻上。

同时，这类药物并非没有风险。生殖器感染、脱水相关问题以及酮症酸中毒等注意事项，需要根据具体药物与个人情况得到解释；合并其他治疗时还要考虑相互影响。[39] 本书不把获益扩大为人人适合，也不把潜在不良反应扩大为人人受害。服用此类药物的人，不应自行采用极端禁食或把疾病期间的用药处理交给网络口号。

五、图谱的最后一列，应该是待问的问题

还有其他治疗类别，不能因本章没有逐一展开，就被理解为不存在或无价值。本书不是完整药理教科书，也不提供剂量与替换规则。更有用的图谱最后一列，是患者可以核实的内容：目前为什么采用这一种，主要希望改善什么，哪些不适需要报告，是否有费用或执行困难，何时复评。不同药物可以有相同的问题框架，却不能被强行给出相同的答案。

三律在药物讨论中的价值，不是替每个类别盖上“违背”或“符合”的章。它帮助我们看见一个具体人是否被理解，治疗是否存在可行路径，生活目的是否仍被保留。一个没有临床验证的三律评分，不应压过已有证据；一个有证据的药物，也不应压过患者的全部叙述。让两者各司其职，才是图谱重建的意义。

带走的话：机制、获益、风险与个人处境应当分别说明，不用一个价值标签代替整张药物地图。

CHAPTER

第二十三章 糖化血红蛋白不是奖牌

好的目标要保护人，不应该让人为了达标而失去安全。

一、平均值不能讲完一天

糖化血红蛋白可以帮助了解一段时间的血糖状况，但它不是一个人每时每刻经历的完整记录。相同或相近的结果，可能伴随不同程度的低血糖、波动与治疗负担。适合的评估需要结合具体监测、症状和个人条件，而不能只凭一个平均指标宣布照护已经结束。[10]

这并不是取消糖化血红蛋白的价值。平均信息与过程信息解决不同问题，可以相互补充。SDE的提醒在于，不要让一个显露吞掉形成它的差异序列；医学的提醒则在于，也不要因为过程复杂，就放弃经过研究与验证的指标。两种提醒共同作用，才不会把指标崇拜换成对指标的轻率否定。

二、目标不是所有人共同的竞争排名

设想一个教学情境：同一家庭的两位成员拿着不同的治疗目标互相比较。一位以为自己的目标更严格，说明更努力；另一位以为目标较宽，说明医生放弃了自己。事实上，个人目标可能受年龄、病程、合并情况、低血糖风险与功能状态等因素影响。[10] 目标不是奖励，也不是人格评语。

当目标被当作成绩单，患者可能不愿报告低血糖或真实困难，担心被认为执行不好。这样一来，考核恰恰遮住了最需要知道的信息。一个好的讨论，应当让患者可以说“我没有做到”“这段时间太难”“我担心夜里发生问题”，而不是只能带来一组更漂亮的数字。

三、ACCORD的教训需要完整阅读

ACCORD的强化降糖部分，在特定高风险2型糖尿病人群中发现，追求更接近正常的目标并没有带来预期的整体收益，而且出现死亡风险增加。[8] 这一结果要求我们认真对待目标与实施方式的边界，却不能被改写成“所有降低血糖的治疗都在慢性杀人”。后一句删除了研究人群、策略与比较条件。

它也提醒我们，不应将不良结果简单归因于某一个未经充分证明的机制。研究观察到了什么，与我们解释为什么发生，是不同层次。发生学可以提出对治疗过程的追问，但不能借此宣称已经发现“自由律被压制”就是死亡增加的原因。理论要面对研究，而不是把研究中的未知当作自己的胜利证据。

四、低血糖不是为了健康必须付出的考验

低血糖需要得到预防、识别和适当处理，尤其在使用某些治疗的人群中。反复或严重低血糖，应当促使专业人员重新评估方案与支持条件。[10] 患者不应被要求把颤抖、出汗、意识变化等危险表现当作“控制有效”的代价，也不能因为害怕被批评而隐藏这些经历。

每个有相关风险的人，应当向自己的医疗团队确认适合自己的处理与求助计划。若出现意识改变、无法安全吞咽、抽搐或需要他人帮助的严重状况，应立即寻求急救，不向不能安全吞咽者强行喂食饮水。这里不把一本通俗书扩展为完整急救流程；它强调的是，安全计划应该在危险发生之前就被说明，而不是事后让患者自己猜测。

五、让目标成为一份共同理解

一个可以共同理解的目标，不只写下数值，还应说明为什么这样设定，怎样观察安全性，哪些生活条件需要支持，什么时候重新讨论。它既不是医生单方面发出的命令，也不是患者单方面宣布的愿望。事实、风险、能力与偏好，需要在同一个决定中出现。[20]

本章因此提出一种不同的“达标”：不是把人送到一个数字之后就不再问，而是使他知道这个数字为什么重要，也知道自己没有被数字替代。若治疗目标帮助他生活，它就完成了应有的工作；若目标使所有不适都变成必须隐瞒的失败，目标的使用方式就需要重建。

带走的话：糖化血红蛋白用来帮助决策，不用来评判一个人是否足够努力。

CHAPTER

第二十四章 缓解不是治愈，也不是所有人的义务

希望需要真实的条件，不能靠把限定条件删掉来扩大。

一、先区分预防、管理与缓解

原稿多次使用“逆转”，希望打破一旦患病就只能等待恶化的想象。这种希望有价值，但需要更准确的词语。降低尚未患病者的发展风险、改善已经患病者的管理，以及达到某些2型糖尿病缓解标准，是不同问题。把它们都称作逆转，会使一项研究的结果被错误地借给另一群人。

DPP研究考察的是高风险、尚未达到糖尿病诊断的人群中，生活方式干预或二甲双胍能否减少或延缓糖尿病发生。[12] 它支持预防与支持的价值，不是证明所有已患糖尿病者都可停药。研究对象一旦被换掉，原本真实的结果就可能变成不真实的许诺。

二、DiRECT证明了可能，也保留了条件

DiRECT在特定的2型糖尿病人群中，通过由基层医疗支持的结构化体重管理计划，观察到了部分参与者达到缓解。[13] 这使“任何生活与体重管理都不可能改变病程”的说法站不住脚，也说明支持不应只停留在一句少吃多动。

但它不是人人适用的家庭禁食处方。参与条件、专业监督、药物管理、食物重新引入和长期支持，都属于研究中的重要组成部分。把这些条件删掉，只保留“减重后停药”，就不再是在介绍研究。未达到缓解的人，也不能因此被认定为缺少意志或未能掌握三律。疾病差异与支持条件，不能被一个成功率抹掉。

三、为什么专业共识选择“缓解”

2021年国际共识使用“缓解”而非永久治愈，通常以停止常规降糖药物至少三个月后，糖化血红蛋白仍低于6.5%作为判定依据，并强调持续观察与尚待研究的问题。[14] 这是一套用于专业判断的定义，不是鼓励患者为了获得缓解称号而自行停药。

选择这个词，是承认改善可以真实发生，同时承认高血糖可能再出现、既往风险仍需关注，长期结局也有不确定性。一个严谨的词比一个响亮的词更能保护希望，因为它不要求现实永远符合宣传。希望可以建立在部分改善、持续支持与可修正的目标上，不必只有彻底治愈这一种形态。

四、需要治疗的人不比缓解者失败

设想一个教学情境：两位患者共同参加支持项目，其中一位达到缓解，另一位虽有改善却仍需要药物。如果项目只庆祝前者，后者可能把真实进展看成失败。这样的评价将一种临床状态变成了道德等级，既忽略病程差异，也可能诱使人为了获得认可而减少必要治疗。

本书主张把个人进展写完整：风险有没有得到更好管理，症状与负担有没有被处理，是否建立了可持续的支持，生活中哪些事情重新成为可能。缓解是某些人可以讨论的重要目标，但不是每个人必须完成的主体性考试。没有达到缓解，不等于没有发生有价值的重建。

五、不要用极端行动购买一个称号

禁食、快速减重或自行改变治疗，对不同人有不同风险，尤其需要考虑正在使用的药物、糖尿病类型与其他健康情况。[9][11][39] 本版撤去原稿中脱离安全评估的激进操作设想。读者不应把饥饿、虚弱或酮体变化理解为身体正在恢复自由的必经证明。

发生学关注条件，便应承认专业支持也是条件；关注差异，便不能让所有人走同一条路；关注幸福，便不能让缓解的名义成为新的羞耻来源。真正值得扩大的是可靠帮助的可及性，而不是对结果的无条件承诺。让更多人获得可改善的机会，与声称每个人都能够被逆转，是两件不同的事。

带走的话：缓解可以是目标，不能成为自行停药的理由，也不能成为评判患者的等级。

CHAPTER

第二十五章 吃饭、活动与愉快不是三个敌人

健康安排若要持续，必须给人的日常留出能够参与的位置。

一、餐桌为什么会变成诊室的延长线

设想一个教学家庭：一位成员确诊糖尿病后，每顿饭都有人提醒什么不能吃。关心越来越密集，饭桌越来越安静。患者有时为了避开争执，反而不愿让家人知道自己吃了什么。这个情境不证明饮食建议没有价值，它说明建议进入关系之后，可能与原来目的不同的效果。

三律能够帮助重新提问。特征律问：这个家庭平时怎样买菜、做饭、共同进食？自由律问：安全范围内有哪些真实选择，而不只是禁令？幸福律问：餐桌上的共同生活是否仍被允许？这些问题不替代营养建议，却使建议不至于以孤立患者为代价。健康不应让一个人永远成为餐桌上的被检查者。

二、从禁止清单到整体安排

营养管理需要结合个人情况，而不是由一本书为所有人提供同样的食谱。[11] 对现实生活而言，更有帮助的问题常常是：工作日有什么可获得的选择，食物份量怎样理解，家人是否愿意共同调整，外出或特殊日子如何提前与团队讨论。选择的结构比单纯积累禁忌更接近长期执行。

这也避免另一种误解：既然愉快重要，就不应限制任何食物。愉快不是忽略风险的许可证，而是需要在合理安排中保留的生活价值。一个人可以享受吃饭，同时认真管理健康；也可以承认某些改变不容易，而不必把自己归为没有自控力的人。过程中的协商，比好人坏人的分类更有建设性。

三、运动不是用来抵消一顿饭的惩罚

如果活动被安排成吃多之后的惩罚，它就很难成为愿意长期保持的生活。适合的身体活动可以服务于体能、健康与生活质量，而不只是体重或血糖图上的一个结果。

[11][28] 对使用有低血糖风险治疗的人，活动与药物、进食之间的协调尤其需要事先获得专业指导。

在安全范围内选择喜欢、可到达、能够重复的活动，并不比追求统一强度缺少认真。对于有些人，最先需要改变的是缺少陪伴或安全场所；对于另一些人，则是对活动的不确定与恐惧。发生学的工作，是把这些条件找出来，而不是用一句“动起来就会好”跳过它们。

四、照护者与患者都需要被看见

糖尿病管理有时会悄悄变成家庭里某一个人的全职任务：提醒、采购、记录、陪诊、应对担心。若我们只问患者是否得到帮助，而不问帮助由谁承担，就可能把整体照护的成本藏进家庭。照护者的时间与恢复机会，同样属于需要讨论的条件。

在患者同意的前提下，家庭可以明确哪些事情需要共同支持，哪些决定由患者自己参与承担，哪些问题应该交给专业人员，而不是在家里反复争论。一个人不需要被完全照看，才能得到爱；照护者也不应因为表达疲惫，就被认为不够负责。关系中的可持续性，是本书所说幸福律的一项实际要求。

五、从“控制住我”转向“帮助我参与”

第五编最后回到主体。主体参与不是拒绝指标，也不是要求身体永远自然运行，而是这个人的理解、困难与目标能够影响方案，并得到可靠证据和专业能力的支持。胰岛素、其他药物、营养、活动、监测与关系，不是固定分属压迫或自由两端的東西；它们怎样被组织，才决定这个人实际拥有怎样的行动空间。

当一个人能够安全地生活、理解必要保护、表达困难、获得适合的支持，并参与下一次修正，我们就不必用“全面逆转”的口号才看见进展。发生并不总是戏剧性的翻转，也可以是一段不再只围绕危险旋转的日常。让代谢与生活共同持续，是比让某个数字永久获胜更完整的目标。

带走的话：不要让健康取消餐桌、关系与愉快，也不要让愉快取消可靠的保护。

PART

第六编 让健康发生的共同工程

前五编不断把两个问题放到一起：什么值得保护，保护怎样真正进入一个人的生活。最后一编不再寻找万能解释，而是把三律转成可以实践、可以记录、可以接受反对意见的工作方式。它从一次门诊开始，走到家庭、制度、知识工具与研究。

CHAPTER

第二十六章 一次门诊需要两种记录

检查结果说明身体的一部分，生活记录说明方案进入身体的道路。

一、不是两套真理，而是两种不能互相替代的信息

一次门诊通常带着许多已经成形的材料：化验、影像、诊断、处方和既往病史。患者也带着另一种材料：什么时候不舒服，哪一项安排总是做不到，家里发生了什么，自己最担心什么。第二种材料往往没有固定表格，甚至还没有被整理成完整句子。它因此容易迟到，却不意味着价值较低。

本书所说两种记录，不是要求另建一套与医学病历对抗的“意义病历”，也不是说个人体验能够推翻所有测量。它要求不同信息在决定中各有位置。一个检查结果可能改变风险判断，一项生活困难可能改变执行方式，一个新症状可能要求进一步评估。共同决策的核心，是使这些信息在有依据的选项之间发生联系，而不是只给患者一个同意或不同意的按钮。[20]

二、把九宫格变成九个入口，而不是九项任务

原稿提出三界与三律交叉的九宫格，可以用来防止问题被一种视角垄断。理念界与特征相交时，我们问：当事人怎样理解自己的具体情况，哪些概念被误解？理念界与自由相交时，我们问：他是否知道可讨论的选项与理由？理念界与幸福相交时，我们问：他希望照护服务于怎样的生活，而不是只服务于什么数字？这三问关注的是理解的组织，不是检查一种脑内病变。

转到现实界，特征问题要求记录真实的身体与生活条件，不能只写理想日程；自由问题要求检查时间、费用、交通、技能和支持是否让方案可行；幸福问题则要求注意实际负担与恢复机会。再转到自我界，我们询问患者怎样体验这些变化，是否感到有资格提出疑问，以及哪些结果对他真正重要。九个入口可以按需要选择，不要求每次复诊填满九格，更不能把空格认定为病理缺陷。

三、一段构拟对话怎样改变问题

下面是一段教学构拟，不来自真实门诊。患者说：“我知道应该按时复诊，但最近每次来都要请假。”医生若只回答“健康比工作重要”，并没有处理他面对的冲突。另一种对话可以先确认风险与必要随访，再询问请假的实际困难、现有复诊安排是否有协调空间，以及哪些信息可以提前准备。结论由真实医疗条件决定，问题却不再只是患者重不重视健康。

患者又说：“我怕说不舒服，您就觉得我想停药。”此时需要澄清，报告不适不是拒绝治疗，复评也不预设一定停药。这样一句解释，可能使原来被隐藏的信息进入讨论。我们不能保证任何一次对话必然改善临床结局，但可以清楚指出它在过程上改变了什么：患者不再需要先选择一个立场，才有资格提供自己的经验。

四、用复述检查理解，不用点头证明完成

一次说明之后，患者点头，并不一定意味着他知道回家怎样做。语言、紧张、信息量和既往理解，都可能影响交流。团队可以请患者用自己的话说说接下来的安排，以检查哪些地方仍需解释；这不是考试，而是检验说明有没有被有效传递。[20]

同样，患者也可以复述自己的主要问题，请团队确认是否理解准确。这样做形成双向校正，而不是只有专业人员检查患者。SIO在这里不是三个抽象角色的静态图，而是一段能够纠错的互动：对象被共同澄清，行动被共同组织，主体在理解与承担中出现。理论的价值，体现在这种具体互动能否被改善。

五、有限时间里，先保护最重要的问题

现实门诊不可能无限延长，因此整体照护也需要排序。急症与明显安全问题优先，关键风险与当前主要困难进入核心讨论，其他问题可以记录并安排后续处理。完整不是一次解决所有事，而是不把尚未处理的事假装成已经不存在。

一页简明记录可以帮助完成这种排序：当前治疗与重要病史、最需要说明的变化、最难执行的安排，以及本次希望问清的一两个问题。附录二提供的是这种沟通工具，不是诊断量表。它的目标是减少遗漏，不是把患者变成更勤奋的填表员。一次门诊需要的不是更多纸张，而是让原来进不了决定的信息有机会被接住。

带走的话：把医学信息与生活信息接到同一个决定里，不用另一套表格继续遮住人。

CHAPTER

第二十七章 一段可修正的重建过程

重建不是保证每一步都对，而是让每一步都能把经验带回下一步。

一、从想改变一切，到找到一个可工作的起点

设想一个教学家庭：父亲需要长期风险管理，母亲承担大部分生活安排，成年女儿经常远程提醒。三个人都很努力，却越来越紧张。若把问题定义成父亲不配合，办法就是更多监督；若把问题定义成母女控制过多，办法又可能变成完全撤去支持。两种定义都让某一个人承担全部原因。

发生学的第一步，是把眼前状况写具体。哪些医学问题正在得到处理，哪些信息还不清楚？什么行为反复引起冲突？谁承担哪些任务？哪一件事最值得先改变？这些问题不预设家庭就是病因，而是寻找当前行动结构中的可调整环节。起点越具体，后续越容易判断有没有变化。

二、一次循环可以从六条不同的路进入

SDE三方程提醒我们，不必永远从同一个位置开始。有时从显露追问过程：为什么这项安排总是漏掉？有时从显露追问条件：什么环境使它难以完成？也可以从差异序列追问新的显露：改变执行顺序后出现什么？从差异序列追问条件变化：一次尝试是否增加了理解或支持？还可以从条件出发设计更可行的过程，或观察新的条件下哪些结果开始出现。这里形成六条双向观察路径，而不是六项已经验证的疗法。

例如，家庭先发现争吵总在晚饭时发生，可以追问这段互动怎样一步步升级；也可以发现晚饭同时承担吃饭、服药提醒和工作汇报太多任务，转而讨论是否需要重新安排沟通。改变一项关系之后，再看冲突是否减少、必要保护是否仍然落实。这种设计不会直接证明血管发生了改善，但它能使一个生活层面的假设接受观察。

三、行动必须写出边界

任何尝试都应明确不改变什么。一个沟通或日程调整，不应暗中变成自行撤药；一个活动安排，不应脱离安全评估逐渐升级为负荷挑战；一个记录工具，也不应替专业人员解释急性症状。边界不是阻止生成，而是使生成不靠把危险留给患者来换取成功故事。

还需要说明由谁观察、出现什么情况停止、何时联系专业人员。对于纯粹生活组织的调整，停止条件可能是负担明显增加或冲突加剧；对于涉及治疗的安排，决定权与监测责任应当由合适的医疗团队承担。本书不提供统一的四周逆转疗程，因为统一时长不能替个人条件作保证。

四、回写不只记录好消息

假设一家人尝试把健康问题集中在一个事先同意的时段讨论，减少全天候提醒。下一次回看时，不能只记录“气氛好一些”，还要问有没有遗漏必要事项，谁承担了新的隐形劳动，患者是否真的更愿意表达问题。如果冲突转移到另一个时段，或者母亲需要额外做大量记录，方案就还没有被充分解决。

这种对代价的记录，是幸福律对自身的约束。我们不能只看一个人的轻松，而看不见另一个人的负担；也不能只看短期和谐，而忽略重要风险变得无人负责。回写的对象不只是结果S，还包括改变过的过程D与条件E。这样，下一轮行动才不是对原计划的盲目加码，而是对真实经验的回应。

五、重建的成熟标志是可以修正

一套计划若需要反复宣称自己完整，可能很难承认现实不配合。成熟的重建恰好相反：它能够说清哪个假设没有成立，哪些环节不适合当前家庭，哪些问题需要别的专业帮助。没有产生预期改变，并不意味着患者缺少信念，也不意味着只要再坚持就必定成功。

本章的循环可以概括为：看见具体状况，提出有限假设，安排有边界的行动，记录结果与代价，再决定保留、改变或停止什么。它是工作纪律，不是治疗承诺。发生学在这里最大的贡献，是让失败不再只是人的失败，而成为方案需要学习的信息；让成功也不再只是一个漂亮结尾，而成为下一次判断的起点。

带走的话：把结果、代价和失败一并回写；下一步应当从现实出发，不从维护理论出发。

CHAPTER

第二十八章 医疗制度把什么奖励出来

当一种结果最容易被看见，其他重要的工作就可能被悄悄挤到边缘。

一、数字不仅在诊室里，也在制度里

原稿对数字医学的批判，不应只落到某一位医生身上。假设一个机构主要根据达标率、服务量与完成表格的速度评价工作，那么解释、协调、了解负担和处理长期困难，可能不容易显出同样的成绩。这里说的是一种需要实证考察的制度机制，不是宣布所有机构都如此，也不是给具体人员推定恶意。

发生学要求把行为放回条件：某种工作为什么反复出现，什么使另一种工作难以发生？若只责备个人缺少人文关怀，而不看时间、人员、组织与评价方式，批判本身也停留在完成态的道德判断。制度不是抽象背景，它可以改变一段互动真正拥有多少空间。

二、不能用一个幸福总分替换全部指标

一种容易的改革，是把原来的血压血糖达标率，换成满意度、意义指数或三律总分。这样看似从数字走向人，实际上只是更换了计分项目。如果一个人的复杂生活仍被压成单一排名，哪些困难可以表达、哪些结果值得奖励的逻辑可能没有改变。

尤其是未经验证的自制量表，不能因为拥有九宫格、雷达图和小数点，就获得医学权威。患者的重要结局、体验与治疗负担可以被研究，但测量工具需要说明内容、可靠性、解释范围和适用条件。三律作为观察框架有价值，并不等于任何按三律命名的分数都值得考核。反对指标崇拜的体系，应当首先拒绝自己的指标崇拜。

三、利益冲突需要透明，不需要阴谋包办解释

药物、检查、设备、课程和健康咨询，都可能涉及商业利益。对利益冲突保持警惕是合理的，但不能把某种治疗的所有使用都解释为牟利，更不能把没有药物的服务自动视为没有商业偏向。一个出售“自然逆转”课程的人，同样可能从夸大风险与疗效中获利。

比较公平的要求是透明与可检验：提出建议的人有什么相关利益，收益与风险怎样被表达，使用了哪些证据，有没有独立评估，失败能否被公开。这里没有哪一个体系可以免检。SDE或三律服务若未来进入市场，也应接受同样的质疑，而不能以关怀人的名义绕过事实责任。

四、可及性决定了“选择”是否真实

一项方案在专业上可以讨论，不意味着患者现实中能够获得。费用、交通、语言、数字技能、家庭支持和就诊连续性，都可能改变选择的可行性。把这些条件排除之后再强调患者应当主动，就容易把制度提供不足转换成个人责任。

自由律因此不只询问患者愿不愿意，也询问他有没有实际路径。一个看似小的组织改进，如更清楚的信息、更可协调的随访或更适合阅读的材料，可能减少某些障碍；但其效果仍需观察，不能仅凭善意宣布成功。制度中的生成，不是不断增加服务名称，而是让原来无法发生的可靠帮助真正发生。

五、怎样评价一个更好的系统

一个更好的系统至少应容纳多种结果：必要风险有没有被处理，患者重要结局怎样变化，负担由谁承担，失访和退出的人去了哪里，资源是否只流向最会表达的人。这些问题需要不同方法，不能要求一张表独自完成。某些方面可用经过验证的测量，某些需要访谈、观察或流程分析；方法之间要说明关系。

本书不声称已经证明某种制度安排最优。它提出的是研究与治理方向：让系统奖励解释、协同、纠错与连续支持，而不只奖励可立即呈现的完成数。主体性不仅是患者内心的一种态度，也与制度是否允许他被听见有关。若改变了这一条件，三律才可能从个人建议走向共同工程。

带走的话：改革不能只换一套分数；要改变哪些问题能被看见、哪些帮助能真正发生。

CHAPTER

第二十九章 AI与知识生态：不让新仪表接管人

智能工具可以扩展理解，也可能把未经核实的判断包装得更加流畅。

一、从信息回答器到可追溯的知识环境

原稿提出SIO-MedGPT等设想，尝试把个人资料、理论与智能工具联系起来。这个方向可以作为研发议题，但不能把设想中的能力写成已经完成临床验证的产品。一个系统能够流畅谈论九宫格，或者生成一张个人雷达图，并不说明它能够诊断三律失衡、预测心梗或选择用药。

更稳妥的起点，是帮助整理可以核实的信息：药物清单是否完整，用户准备问什么，某条医学说法来自哪里，证据适用于哪些人群，资料有没有版本变化。这样的知识环境不是越会说越好，而是越能暴露来源、限制与未解决的问题越好。世界卫生组织关于健康领域大型多模态模型的治理文件，同样强调可靠性、人的自主与隐私等方面的风险。[40]

二、把三律用于约束工具，而不是给工具加权威

特征律要求系统不把不同患者当作同一种模板，也不根据少量聊天内容编造病史；自由律要求用户能够查看、更正和拒绝某些记录，知道什么时候应由专业人员判断；幸福律要求工具减少真实负担，而不是用频繁提醒与不断评分占据生活。三律在这里首先是产品问题，不是诊断标签。

例如，一个工具把复杂的复诊材料整理成一页待问问题，可能比自动给出“你应换药”的答案更适合当前能力边界。它也可以明确说，现有资料不足以判断某项因果。这样的不确定性并非性能失败，而是对任务性质的尊重。系统越能连接生活与医学，越不能把连接能力误认为处方权。

三、复合主体不等于把责任交给模型

人在工具帮助下可以形成新的理解与行动能力。本书把这种关系看作值得研究的人—智能器具协作，而不把模型当成一个替人负责的医生。患者需要知道哪些信息来自原始资料，哪些是自动总结，哪些属于推断；专业人员也需要能够检查关键内容，而不是只接收一个不可追溯的答案。

真正的协作要允许修正。假如用户说系统记错了药名或时间，工具应当能明确更正并保留必要的版本信息，而不是继续用错误资料推理。假如模型根据一个旧版指南给出过时解释，知识环境应当能够指出版本差异。发生学的回写，在这里不是把所有输出不断累加，而是让错误也能够改变后续生成的条件。

四、数据越私人，边界越需要清楚

健康信息可能包含疾病、心理体验、家庭关系与日程等敏感内容。收集之前需要说明用途、访问范围、保存方式与删除机制，不能因为建设“我的知识生态”就默认所有内容都应永久汇入一个平台。技术上能够记录，与当事人愿意并适合被记录，是两道不同的问题。[40]

同样，家人、研究者或服务人员能够帮助使用工具，并不自动意味着他们应看到全部资料。一个有主体性的系统，应当支持适当授权，而不是把透明解释成对所有人完全公开。对于没有数字技能或不愿使用智能工具的人，照护也不应因此降级。自由包含借助工具的机会，也包含不被某一种工具排除的权利。

五、先证明减少了什么负担，再宣传增加了多少智能

一个健康知识工具可以先接受很具体的评价：整理的信息是否准确，来源能否核实，用户是否更清楚自己要问的问题，错误是否得到及时纠正，使用时间与焦虑是否增加。至于能否改善临床结局，需要另外的研究。不能把点击次数、聊天长度或满意评价直接当作医学效果。

这也是本书给未来SDE平台的一项要求：不要只展示最精彩的回答，要保留失败、误导和退出案例；不要让新术语遮住原有治疗的证据；不要用“复合主体”把责任分散到无人承担。智能可以成为共同工程的一部分，但它首先应当帮助人更清楚地参与，而不是使人更难知道谁正在作出判断。

带走的话：健康AI先要可追溯、可更正、有边界；会生成解释，不等于已经能够负责治疗。

CHAPTER

第三十章 让三律先接受自己的检验

一个要求医学重视证据的框架，也必须允许证据改变自己。

一、从能解释一切，到可能被某种结果否定

如果每一次改善都被解释为三律恢复，每一次失败又被解释为三律还没有真正恢复，那么框架就很难接受检验。它可能永远有话可说，却无法说明什么结果会使自己需要修改。理论要进入研究，必须把自己的雄心缩成若干具体命题：在什么人群、通过什么新增安排，预期哪一项结果以怎样的方式改变？

这并不要求哲学的全部内容都直接变成实验变量。三律可以保留价值与分析层面的意义，但其临床效果主张需要单独承担证据责任。一个框架帮助人表达问题，与它能够降低某种事件风险，是不同强度的主张。先证明前一项，不会自动拥有后一项；前一项未被支持，也不应靠更宏大的后一项遮掩。

二、一个可以开始讨论的研究问题

可以提出这样一项尚未实施的研究设想：在接受规范照护的成年人中，增加一个明确描述的三律沟通与回写支持模块，是否减少治疗负担并改善某项预先选定的患者重要结果，同时不损害风险管理与安全？这里没有撤去必要治疗，也没有把对照组设计成只有药物、完全没有生活方式支持的假想医学。

为了判断新增框架的特异价值，还可以讨论采用接触时间与关注程度相近的比较安排。否则，即使干预组改善，也可能主要因为多获得了时间、陪伴和教育，而不是因为三律结构本身。这样的结果仍可能有实践意义，但应如实归因。研究不是替一个名称争功，而是找出哪些具体帮助值得保留。

三、变量需要经过从词到动作的转换

“自由增加”可以指很多东西：知道更多选项、执行困难减少、参加活动更容易，或对决定更有参与感。若不先定义，就可能在结果出来后挑选最有利的含义。同样，“幸福改善”不应由研究者随意打一个总分。应选择合适的、经过验证且适用于研究人群的测量，必要时先做质性与测量研究，而不是直接宣布自制指数有效。

S、D、E也需要同样处理。当前结果怎样测，行动序列怎样记录，条件变化怎样识别，缺失数据如何处理，都应提前说明。一个形式上漂亮的三方方程，不会自动解决这些问题。相反，能否完成这些具体化，才决定它是否真正增加了研究组织能力。

四、把无效、不适与退出写进最初的设计

一项支持模块可能没有效果，也可能增加负担，使一些人感到被过度询问，或者让照护者承担更多工作。这些不是只有研究失败后才值得解释的意外，而应在设计时就被考虑。退出者、失访者和没有完成记录的人，需要在结果中有位置，不能只展示最愿意参与的一组人。

预先注册、明确主要结局、报告方案变化、说明实际干预与比较条件，以及透明呈现不良后果，有助于读者判断研究究竟做了什么。CONSORT 2025提供的是随机试验报告规范，不是给理论颁发有效证书，也不是替代研究设计的方法。[30] 本书引用它，是要求未来研究讲清实际工作，而不是用报告清单制造权威外观。

五、允许框架缩小，才可能让贡献变得真实

研究最后可能发现，三律最有帮助的是整理门诊问题，而不是改变临床指标；也可能发现它与其他以人为中心的方法没有额外差异；还可能发现某种用法增加负担，需要放弃。这些结果都应被允许。一个愿意缩小主张的框架，可能比一个永远宣称医学革命的框架更值得合作。

如果未来证据支持某项具体应用，我们可以准确说明它适用于谁、改变了什么、仍有什么限制。如果证据不支持，就修改或撤回相应主张，而不把责任交给患者信得不够。三律的成熟，不在于拒绝任何失败，而在于它也遵守特征、自由与幸福对自身提出的要求：尊重具体事实，允许真实选择，不让理论的胜利高于人的生活。

带走的话：让理论有明确的失败条件，才能让它的成功不只是自己的解释。

结语 让被保护的生命重新生活

正常值不是生活的终点，离开正常值也不是自由的证明。

这本书从一张检查单开始，最后回到一个人。不是因为检查单不重要，而是因为它的意义不能由自己完成。一个数值进入生活，需要经过解释、选择、执行、负担与反馈；一段生活进入医学，也需要获得可以被认真讨论的形式。两者之间的工作，不能仅靠更强烈的口号完成。

组成本书的原稿有一种鲜明的急切：它不愿看到患者被压缩成指标，不愿把生命的主动性全部交给外部控制，也不愿让“健康”成为取消日常愉快的理由。这种急切使许多原本容易被忽略的问题变得可见。重编没有撤去这些问题，而是要求它们不再依赖未经核实的数据、过度的药物指控或无边界的逆转承诺。

因为人需要完整的照护，所以我们应当认真管理风险；因为治疗有真实价值，所以我们应当认真处理负担；因为生活条件会影响健康行动，所以我们应当努力改变条件，而不是把困难都交给个人意志。这三句话不互相抵消。它们共同构成了一种更难、也更可靠的立场：保护生命与尊重主体，不应被安排成只能选择一个的两端。

特征律使我们不满足于笼统的人群标签，也不允许随意编造私人标准。自由律使我们寻找真实可走的路径，也不把必要支持误认为失败。幸福律让风险管理重新接到生活目的，也不要求患者必须快乐或把疾病解释成成长礼物。三律彼此约束，才不会分别变成任性、放任与强制乐观。

SIO帮助我们看见关系中的主体、互动与对象，SDE帮助我们追问显露、差异序列与特征纠缠怎样互相形成。它们可以使一种静态判断变成一段可追问、可修正的过程。但理论若想承担临床效果主张，就仍须进入具体研究。生命的复杂性不是免于验证的理由；人的意义也不应成为遮蔽事实的帷幕。

对读者来说，本书最希望留下的不是一组新的禁令，而是几种可以带走的能力：知道何时需要立即求助，知道一个结论的证据边界，能够更具体地表达自己的变化，能够询问治疗的目的与替代，能够让下一次行动吸收这一次经验。你不必完全接受本书的哲学，仍然可以要求这些基本条件得到尊重。

对于医护、教育者与研究者，本书提出的也不是放弃既有知识，而是在既有证据之上继续问：谁的经验尚未进入决定，哪些负担被藏在家庭，哪些支持只存在于纸面，哪些理论主张还没有被检验？这些问题不会使医学更轻松，却可能使保护更贴近真实的人。

发生学重建因此没有一个必须以停药、逆转或全然独立结束的剧本。有些人能够减少某项治疗，有些人需要持续支持；有些人恢复更多功能，有些人在局限中找到新的生活安排。只要我们不虚构结果，不把风险浪漫化，不以理论优越感替代患者的具体处境，就仍有许多值得做的工作。

医学要帮助人活下去，也要持续询问，被保护的生命怎样活着。希望可以有边界，改善可以不彻底，支持可以长期存在；这些都不使人的价值减少。真正需要被放下的，是那种只许一个数字获胜、只许一个体系正确、只许一种人生算作成功的想象。让可靠保护与生活可能一起发生，是本书愿意继续承担的问题。

APPENDIX

附录一 术语与阅读边界

一、理论语言怎样使用

SIO：主体、互动与客体。在本书中，它是分析具体关系的框架，不是三个固定的身体部位。使用时要说明尺度；患者的知情参与与细胞的选择性反应，不能因为都被称为“主体”就互相代证。

SDE：显露、差异序列与特征纠缠。S不是结构的缩写，D不只是泛泛的运动，E也不是能量。三方程 $S=F(D,E)$ 、 $D=G(S,E)$ 、 $E=H(S,D)$ 强调三个维度相互规定；本书没有为这些函数建立可用于临床预测的数值模型。

特征律：要求判断保持对具体差异的敏感。它不授权读者根据身高、性格或自我感觉，为自己编造未经证实的安全阈值。

自由律：关注实际可行的路径、参与与调整能力。自由可以由可靠的外部支持共同形成，不等于拒绝药物、设备或他人帮助。

幸福律：使保护与当事人珍惜的生活保持联系。它不是即时快乐最大化，不要求患者把疾病视作礼物，也不把疾病解释为意义不足的惩罚。

三界：理念界、现实界、自我界，是本书组织理解、实际条件与个人体验的观察入口，不是三种独立病因。三界与三律交叉的九宫格用于发现问题，不是经过验证的诊断量表。

六个尺度：分子、细胞、组织、器官、系统与人的生活。尺度之间需要建立具体连接；分子机制不能直接替人格或生活价值作结论。

回写：把一次行动产生的结果、失败、代价与条件变化带回下一次判断。回写不是只保存成功，也不是把所有信息无限累积。

六条路径：S与D、S与E、D与E之间的双向追问。它们提供不同的分析入口，不是六种已经验证的治疗方法。

二、证据语言怎样区分

因果因素不必是唯一原因，也不必使结果必然发生。风险描述的是某种结果发生的可能性，必须说明人群、时间与比较。一个因素既可以是前一阶段的结果，也可以参与后一阶段的损害；因此，“只是信号”不能自动成为免于干预的理由。

参考区间、诊断门槛、风险变化与治疗目标是不同概念。参考区间不等于个人绝对安全，诊断门槛也不等于所有人的治疗方案。个体化应在可靠证据与具体条件之间进行，而不是随意宣布公共标准不适用于自己。[1][2]

替代指标能够提供重要信息，但不应自动替代患者重要结局。影像改善、实验室指标改善、症状改善与临床事件减少，需要分别说明；它们可以相互支持，不能互相冒名。

机制解释说明一种作用怎样可能发生，临床效果需要相应比较。教学构拟用于展示问题，不是实际病例。研究设想是尚未实施的方案，不是已经取得的结果。本书所有未获验证的三律应用均按后一层次理解。

三、医学词语的有限说明

LDL相关讨论区分胆固醇的生理用途与致动脉粥样硬化脂蛋白的暴露风险；本书既不妖魔化它，也不否认其因果证据。斑块不是可用强水流冲掉的油垢，血管壁结构、时间与临床结局需要分别理解。[4][5]

家庭血压监测与动态血压监测是不同情境的信息来源，应使用合适方法并接受专业解释。曲线不是自由或幸福的直接图像，不用于自行改变治疗。[1]

糖化血红蛋白提供一段时间的平均信息，不完整呈现每一次血糖变化。连续葡萄糖监测可以提供补充信息，但设备读数仍需要合适的解释与行动计划。[10]

2型糖尿病的“缓解”不等于永久治愈，也不适用于把1型糖尿病患者的必要胰岛素治疗撤去。缓解的判定与后续随访应由专业人员处理，不以自行停药取得一个称号。[9][14]

APPENDIX

附录二 复诊与生活观察页

本页用于减少沟通遗漏，不是健康评分，不预测发病，也不提供处方。可以只填写与本次就诊相关的部分。不必每天填满，不必把个人资料上传到任何平台。症状急重时先就医，不为完成记录而等待。

一、我希望本次讨论什么

姓名或自用代号：_____ 记录日期：_____

本次最希望问清的问题：_____

目前最重要的生活目标：_____

已经确诊、需要告知医护的重要情况：_____

当前使用的处方药、非处方药和其他产品：_____

药物资料请核对包装或正式处方；不要凭记忆猜测名称、剂量或频次。

二、最近发生了什么变化

变化是什么，什么时候开始：_____

通常在什么情境发生，持续多久：_____

是否影响站立、行走、睡眠、工作或其他日常活动：_____

同期是否发生治疗、饮食、活动或工作安排变化：_____

我已经做过什么、向谁求助过：_____

若带来测量记录，请同时说明设备、时间与测量条件，不只挑选最满意或最担心的一次结果。

三、计划在生活中卡在哪里

最难执行的一项安排：_____

困难主要与什么有关：时间、费用、交通、理解、技能、照护责任，或其他条件：_____

已有支持，以及希望获得的支持：_____

愿意参与讨论的人：_____ 本人同意其参与范围：_____

四、离开诊室前确认

这段时间的主要目标与理由：_____

由专业人员确认的执行安排：_____

哪些情况需要联系谁：_____

复评日期与需要准备的信息：_____

我用自己的话复述后，仍不清楚的地方：_____

五、下一次回看

哪些事情确实发生了：_____

哪些事情没有发生，或出现了额外负担：_____

哪些解释仍然只是猜测：_____

下一次希望共同决定保留、改变或停止什么：_____

APPENDIX

附录三 安全边界与急症提醒

一、不等待阅读、不等待记录

出现疑似心梗或脑卒中的突然症状，或严重呼吸困难、意识改变等急重情况，应立即联系当地急救服务。不要先用情绪、压力或三律失衡解释，也不要先尝试散步、呼吸训练或冷热刺激。记录有帮助，但不能延误求助；症状暂时缓解也不应成为自行排除危险的依据。[23]

疑似脑卒中时不要自行假定一定由血栓造成并服用阿司匹林。疑似心梗时先呼叫急救，是否服用阿司匹林遵从专业指导，不服药后等待看看是否好转。[24]

对于存在低血糖风险的人，应事先向医疗团队确认适合自己的识别、处理与求助计划。出现意识障碍、抽搐或不能安全吞咽等严重情况，应立即寻求急救，不强行喂食饮水。本页不是完整的急救操作手册。[10]

二、不把阅读变成自行调整治疗

不要因为指标改善就自行认为治疗已经不需要，也不要因为一次不适就认定全部治疗有害。新症状、疑似不良反应、执行困难或对目标的疑问，都应进入专业复评。复评可以有不同结论，不预设必须减少药物。

不要自行改变服药时间来模仿所谓自然节律。对夜班、日程特殊或存在不适的人，安排需要结合具体药物与临床情况讨论；本书不提供统一的晨服或夜服规则。[27]
[34]

1型糖尿病患者的胰岛素不能被本书的生活方式或哲学讨论替代。生病、进食变化和其他特殊情境下的用药处理，应事先与团队制定计划，而不是临时听从网络传言。
[9][10]

三、不以挑战身体证明理论

本书不认可通过极端禁食、突然高强度运动、反复憋气、剧烈冷热交替或直视太阳来“清理血管”“重启三律”。也不提供脱离个体评估的减药疗程。活动、营养与必要监测，应在适合自身情况的范围内安排。[11][28]

幸福律不要求强迫快乐，自由律不要求拒绝帮助，特征律不要求认为自己例外。任何方法若让人因生病而感到自己不值得被帮助，或要求隐瞒不适以证明方法正确，都违背本书重编后的基本立场。

APPENDIX

附录四 原稿对照与实质修订说明

一、本版怎样处理原始材料

本版的底本是用户提供的压缩包。包内11篇独立论文与180页整书初稿存在重复；整书初稿还收有5项未作为独立文件提供的长篇材料。编辑先核对全部16项，再按论证关系重建六编三十章。以下页码指初稿印在页面上的正文页码，不是PDF阅读器的物理页序号。

本版不是逐句忠实转录，也不是保持原有字数的合订本。重复开场、重复结论、对话残留、纲要式条目和彼此冲突的解释被合并、改写或删除；新增了承接、反例、证据界限和教学情境。主题范围予以覆盖，不代表每一句原话都被保留。原始PDF仍作为编辑底本保存，不把其中未核实的临床断言重新标成可靠证据。

二、十六项材料的去向

01 《三律健康学入门：医学哲学范式重构》（初稿1—11页）：核心问题进入第一编，三界九宫与整体照护进入第二十六章，医学史与既有整体医学的关系进入前言及第二编。

02 《三律医学的科学根基：从“免疫—神经—内分泌”三视角看意义三律》（12—14页）：进入第四章；保留跨系统联系的启发，撤回三种系统与三律一一对应的实证化表达。

03 《三律健康学：从价值到意义的范式转移》（15—17页）：进入第二、第五章与结语；将幸福从即时释放扩展为持续的生活目的，避免把患者价值附着在健康状态上。

04《和GPT共创：血脂其实不是问题，血管失去差异才是》（18—31页）：进入第三编；重建LDL、血管壁、变化与累积暴露的关系，删去“血脂没有因果作用”的绝对化结论。

05《从压制到激发的中风心梗预防新范式》（32—38页）：进入第九、第十四、第十五章；把激发改为有依据、有边界的支持，补入急症与运动安全。

06《糖的错觉，自由的真相：一场关于胰岛素的医学革命》（39—45页）：进入第五编；区分糖尿病类型、胰岛素功能和治疗支持，不把激素拟人化为敌人。

07《这不是治疗，是一场标准值下的慢性处决》（46—49页）：其对生活负担的抗议进入第一、第五、第十九章；不沿用把临床治疗概括为处决的标题与结论。

08《数字管理健康教义：其医学本体论与知识论基础的系统批判》（50—53页）：进入第七、第八、第十及第二十八章；区分指标本身与制度如何使用指标。

09《三高治疗的真相：指标正常，却逐步杀死身体的三大机能》（54—60页）：进入第一编、药物章节与负担讨论；移除药物必然摧毁三大系统的总断言。

10《三高治疗：慢性杀人》（61—67页）：其治理批判进入第二十八章；关于伤害的判断改为具体收益—风险分析，不推定所有医护或药物具有伤害意图。

11《数值降压与SIO崩溃：意义三律视角下的高血压管控批判》（68—72页）：进入第四编与第二十六章；把症状、测量、参与与治疗负担纳入可复评关系。

12《翻案三高：从“罪魁”到“信号”》（73—119页）：进入第二编及后三个专题编；保留寻找上游条件的方向，修正信号与原因互斥、代偿必然安全的推论。

13《主流降糖药的SIO三律解构全图谱》（120—128页）：集中进入第二十二章，并连接第二十一、第二十三与第二十四章；按具体机制、适用情境、临床证据和风险重写。

14《LDL的冤情与昭雪》（129—140页）：进入第十一至第十三章；去掉“昭雪即无害”的法庭式结论，不保留未附可核验资料的干预疗效数字。

15《高血压治疗的三律违背结构分析》（141—152页）：进入第十八、第十九章；药理作用与人格自由分层处理，保留不适可被表达和复评的要求。

16《高血压翻案：不是元凶，而是最后的求救信号》（153—178页）：进入第十六至第二十章；纠正统一撤去夜间治疗、以极端刺激恢复节律、只在极高读数才处理等不安全推论。

三、证据、案例与数字的处理

原稿若干段落列出人数、百分比、评分变化或随访结果，却没有提供足以核验的研究出处、病例记录、方法与分母。本版不把这些数字继续作为实证刊载，包括原稿中关于1630例、11820人、75人六个月干预，以及多个复发率、发育或“意义指数”变化的陈述。删除的理由是当前材料不足以支持它们，不是在没有调查的情况下断言这些数字必定伪造。

正文出现的患者、家庭与对话均明确按教学构拟处理。第八章的一千人、一百例与八十例，只是解释相对与绝对差异的虚构算例，不对应实际试验。真实医学研究另以文献编号追溯，研究结果不冒充三律干预的结果。

原稿中的“示例”参考文献、占位出版信息、无法核对的引文和未完成的研究计划，不纳入本版的正式证据链。对已有真实文献，检查其是否真正支持对应结论；尤其修正了用支持LDL因果作用的文献来替“LDL无因果作用”作证的问题。[4]

四、主要医学命题的重写

因果与测量方面：将“三高只是信号”改为上游结果与下游作用可以并存；将“不是唯一原因”与“没有作用”区分；把当前正常与既往累积暴露区分；不以幸存个案或治疗后仍有事件否定比较证据；把参考区间、诊断门槛、风险连续变化与治疗目标分开。[1—9]

药物与主体方面：不把抑制某条通路直接等同于剥夺人格；不将所有外源支持都归为功能退化；不把长期治疗限定为临时过渡；不将减少药物设为唯一成功。承认不良反应和负担，同时要求具体归因与复评，而非由哲学词语直接决定停药。

血脂与血管方面：胆固醇有生理用途，不表示血中致动脉粥样硬化脂蛋白可以任意升高；斑块在血管壁中形成，不是可用运动冲走的管腔油垢；影像改善与事件减少分别论证；自然波动、剪切力或剧烈刺激不自动成为治疗。[3—6][15][16]

血压方面：不根据身高、性格或自我感觉编造私人安全阈值；不把高血压全部解释为情绪或合理代偿；规范测量与必要的院外监测先于曲线解读；不宣称长效药必然抹去生命节律；不普遍撤去夜间治疗，也不统一要求所有人睡前服药。[1][2][27][31—34]

血糖方面：区分1型与2型糖尿病，保留必要胰岛素支持；不以“细胞拒绝”替代代谢机制；按类别区分降糖药，不将作用机制写成必然伤害；承认适当人群的心肾结局证据与相应风险；将糖化血红蛋白、低血糖与个人负担共同讨论。[9][10][17][18][35—39]

生活与逆转方面：区分预防、改善管理与2型糖尿病缓解；不把专业监督的研究简化为家庭极端禁食；不把缓解写成永久治愈或所有人的义务；不以快乐、意义与信念不足解释患者患病；所有急症优先寻求专业救助。[12—14][23][24]

五、理论保留与版本责任

本版保留三律、三界、SIO、SDE、六路径、回写与多尺度观察的理论线索，也保留对机械达标、不可执行的健康任务、家庭隐形劳动与制度激励的批判。改变的是这些线索与事实之间的连接方式：理论提出问题，证据限制临床结论，构拟案例帮助解释，真实结果必须可以追溯。

本书不是原作者已完成新临床研究的声明。未来若取得原稿中某项数据的完整来源，可在审查方法与适用范围后另行修订；不能只因为找到相近标题，就恢复原来的百分比或疗效断言。对本版的医学纠错，也应以同样标准接受。

APPENDIX

附录五 三律支持研究的可检验提纲

一、研究首先要说明新增了什么

以下是尚未实施的研究提纲，不构成招募、医疗建议或临床有效性证明。开展涉及人的研究，需要具备相应专业能力、伦理审查与适用的管理条件。不能把一项尚未完成的提纲写成已经获得支持的治疗体系。

可以从一个有限问题开始：在规范照护基础上，增加明确说明内容与流程的三律沟通和回写模块，是否改善一个预先确定的患者重要结果，并减少或不增加不可接受的负担？新增模块应写成可观察的动作，例如怎样整理困难、怎样形成共同目标、怎样反馈，而不只写“恢复三律”。

二、比较必须公平

对照不应被描写成只给药物、完全没有生活与人文支持的假想医学。比较双方都应获得必要的规范照护；为检验框架自身的增量价值，可以讨论使用接触时间、教育与关注程度相近的比较安排。具体设计需要研究团队根据问题、资源与伦理要求确定。

干预前要明确适用人群与排除情况，说明何种风险必须先交由临床处理，不把急症或需要调整治疗的情况留给沟通模块独自承担。研究结果也不应超出入组人群泛化。

三、结果、过程与条件分别记录

主要结局应当提前确定，测量方法需要适合人群且有足够依据。不能以自制三律总分替代所有结局。临床指标、患者体验、执行困难、实际负担与资源使用可以分别作为研究内容，但必须说明各自的角色，避免结果出来后任挑一项宣布成功。

SDE可用于组织过程记录：S记录哪些结果真实出现，D记录干预如何实施及其变化，E记录影响执行的支持与限制。这样的记录是否增加解释力，需要在研究中判断，不因采用字母与方程就自动成立。

四、让失败与伤害进入报告

退出、失访、未执行、症状、不满、额外照护劳动与数据错误，都应在最初的方案中获得位置。不能只保留完成者，也不能把没有改善解释为患者没有真正理解三律。应预先明确安全响应、方案偏离的记录方式和必要的停止条件。

CONSORT 2025是随机试验的报告规范，不是理论有效性的证书，也不是替代研究设计的方法。将来若采用随机试验，应参照合适的报告要求，透明说明注册、方案、实际干预、比较条件、结果及不良后果。[30]

五、允许贡献比最初设想更小

研究可能支持某项沟通用途，却不支持临床指标改善；也可能发现它与已有方法没有额外差异，或对某些人增加负担。应据此保留、缩小、修改或撤回相应主张。没有得到预期结果，不等于生活与主体不重要，只说明这一种组织方式未获得支持。

一个框架的价值，不在于它永远能够为自己解释，而在于它能否帮助发现原来没被看见的问题，并允许真实结果改变下一步。让三律接受自己的检验，是这本书最后的实践要求，也是它继续生长的条件。

REFERENCES

参考文献与资料来源

本表按正文编号排列。医学研究、专业指南与官方患者资料用途不同：试验用于支持其适用范围内的效果判断，指南用于说明专业决策框架，官方患者资料用于基本解释与安全提示。它们都不证明三律干预已经具有临床疗效。线上资料核查日期为2026年10月2日；正文不复制指南表格，不提供个人处方。

[1] 《中国高血压防治指南》修订委员会等. 中国高血压防治指南（2024年修订版）. 2024. 原始指南PDF: <https://www.chl-bha.org.cn/Public/ueditor/php/upload/20240815/17236841017752.pdf>

[2] American Heart Association / American College of Cardiology et al. 2025 Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. *Circulation*, 2025. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001356. 官方摘要: <https://professional.heart.org/en/science-news/2025-high-blood-pressure-guideline/top-things-to-know>

[3] Blumenthal RS, Morris PB, Gaudino M, et al. 2026 ACC/AHA/AACVPR/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Dyslipidemia. *Journal of the American College of Cardiology*, 2026. DOI: 10.1016/j.jacc.2025.11.016. 官方入口: <https://professional.heart.org/en/science-news/2026-guideline-on-the-management-of-dyslipidemia>

[4] Ference BA, Ginsberg HN, Graham I, et al. Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. *European Heart Journal*, 2017, 38(32): 2459–2472. DOI: 10.1093/eurheartj/ehx144.

[5] Borén J, Chapman MJ, Krauss RM, et al. Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease: pathophysiological, genetic, and therapeutic insights. *European Heart Journal*, 2020, 41(24): 2313–2330. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz962.

[6] Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170000 participants in 26 randomised trials. *The Lancet*, 2010, 376(9753): 1670–1681. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)61350-5.

[7] SPRINT Research Group. A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control. *New England Journal of Medicine*, 2015, 373: 2103–2116. DOI: 10.1056/NEJMoa1511939.

- [8] Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group. Effects of Intensive Glucose Lowering in Type 2 Diabetes. *New England Journal of Medicine*, 2008, 358: 2545–2559. DOI: 10.1056/NEJMoa0802743.
- [9] American Diabetes Association Professional Practice Committee for Diabetes. 9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Care in Diabetes—2026. *Diabetes Care*, 2026, 49(Suppl 1): S183–S215. DOI: 10.2337/dc26-S009. 原文: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12690185/>
- [10] American Diabetes Association Professional Practice Committee for Diabetes. 6. Glycemic Goals, Hypoglycemia, and Hyperglycemic Crises: Standards of Care in Diabetes—2026. *Diabetes Care*, 2026, 49(Suppl 1): S132–S149. DOI: 10.2337/dc26-S006. 原文: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12690178/>
- [11] American Diabetes Association Professional Practice Committee for Diabetes. 5. Facilitating Positive Health Behaviors and Well-being to Improve Health Outcomes: Standards of Care in Diabetes—2026. *Diabetes Care*, 2026, 49(Suppl 1): S89–S131. DOI: 10.2337/dc26-S005. 原文: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12690188/>
- [12] Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in the Incidence of Type 2 Diabetes with Lifestyle Intervention or Metformin. *New England Journal of Medicine*, 2002, 346: 393–403. DOI: 10.1056/NEJMoa012512.
- [13] Lean MEJ, Leslie WS, Barnes AC, et al. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. *The Lancet*, 2018, 391: 541–551. DOI: 10.1016/S0140-6736(17)33102-1. 同一研究的两年随访: Lean MEJ, et al. Durability of a primary care-led weight-management intervention for remission of type 2 diabetes: 2-year results of the DiRECT open-label, cluster-randomised trial. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, 2019, 7(5): 344–355. DOI: 10.1016/S2213-8587(19)30068-3. 作者机构存档: <https://eprints.gla.ac.uk/180894/>
- [14] Riddle MC, Cefalu WT, Evans PH, et al. Consensus Report: Definition and Interpretation of Remission in Type 2 Diabetes. *Diabetes Care*, 2021, 44(10): 2438–2444. DOI: 10.2337/dci21-0034.
- [15] Nicholls SJ, Puri R, Anderson T, et al. Effect of Evolocumab on Progression of Coronary Disease in Statin-Treated Patients: The GLAGOV Randomized Clinical Trial. *JAMA*, 2016, 316(22): 2373–2384. DOI: 10.1001/jama.2016.16951.
- [16] Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC, et al. Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular Disease. *New England Journal of Medicine*, 2017, 376: 1713–1722. DOI: 10.1056/NEJMoa1615664.

- [17] McMurray JJV, Solomon SD, Inzucchi SE, et al. Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. *New England Journal of Medicine*, 2019, 381: 1995–2008. DOI: 10.1056/NEJMoa1911303.
- [18] Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. *New England Journal of Medicine*, 2015, 373: 2117–2128. DOI: 10.1056/NEJMoa1504720.
- [19] American Heart Association. Life’ s Essential 8: Updating and Enhancing the American Heart Association’ s Construct of Cardiovascular Health. 2022. 官方科学声明入口: <https://professional.heart.org/en/science-news/lifes-essential-8>
- [20] National Institute for Health and Care Excellence. Shared decision making. NICE guideline NG197, 2021. 建议全文: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng197/chapter/recommendations>
- [21] Sackett DL, Rosenberg WMC, Gray JAM, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn’ t. *BMJ*, 1996, 312: 71–72. DOI: 10.1136/bmj.312.7023.71.
- [22] Engel GL. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. *Science*, 1977, 196(4286): 129–136. DOI: 10.1126/science.847460.
- [23] American Heart Association / American Stroke Association. Warning Signs of a Heart Attack; Stroke Symptoms. 官方公众识别资料: <https://www.heart.org/en/health-topics/heart-attack/warning-signs-of-a-heart-attack> ; <https://www.stroke.org/en/about-stroke/stroke-symptoms>
- [24] American Heart Association. Aspirin and Dual Antiplatelet Therapy. 官方患者资料: <https://www.heart.org/en/health-topics/heart-attack/treatment-of-a-heart-attack/aspirin-and-heart-disease>
- [25] National Institute for Health and Care Excellence. Multimorbidity: clinical assessment and management. NICE guideline NG56, 2016. 建议全文: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng56/chapter/recommendations>
- [26] Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration. Effect of statin therapy on muscle symptoms: an individual participant data meta-analysis of large-scale, randomised, double-blind trials. *The Lancet*, 2022, 400(10355): 832–845. DOI: 10.1016/S0140-6736(22)01545-8.
- [27] Mackenzie IS, Rogers A, Poulter NR, et al. Cardiovascular outcomes in adults with hypertension with evening versus morning dosing of usual antihypertensives in the UK (TIME study): a prospective, randomised, open-label, blinded-endpoint clinical trial. *The Lancet*, 2022, 400(10361): 1417–1425. DOI: 10.1016/S0140-6736(22)01786-X.

- [28] World Health Organization. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: WHO, 2020. 官方出版入口: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128>
- [29] Levine GN, Cohen BE, Commodore-Mensah Y, et al. Psychological Health, Well-Being, and the Mind-Heart-Body Connection: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation*, 2021, 143: e763–e783. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000947.
- [30] Hopewell S, Chan AW, Collins GS, et al. CONSORT 2025 statement: updated guideline for reporting randomised trials. *BMJ*, 2025, 389: e081123. DOI: 10.1136/bmj-2024-081123.
- [31] National Health Service. High blood pressure. 官方患者资料: <https://www.nhs.uk/conditions/high-blood-pressure/>
- [32] National Health Service. Enalapril; Coronary heart disease—Treatment. 官方患者资料: <https://www.nhs.uk/medicines/enalapril/>; <https://www.nhs.uk/conditions/coronary-heart-disease/treatment/>
- [33] National Health Service. Losartan. 官方患者资料: <https://www.nhs.uk/medicines/losartan/>
- [34] Garrison SR, et al. Antihypertensive Medication Timing and Cardiovascular Events and Death: The BedMed Randomized Clinical Trial. *JAMA*, 2025, 333(23): 2061–2072. DOI: 10.1001/jama.2025.4390. 原文: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12070279/>
- [35] National Health Service. Metformin. 官方患者资料及其不良反应分栏: <https://www.nhs.uk/medicines/metformin/>
- [36] National Health Service. About gliclazide. 官方患者资料: <https://www.nhs.uk/medicines/gliclazide/about-gliclazide/>
- [37] National Health Service. About sitagliptin. 官方患者资料: <https://www.nhs.uk/medicines/sitagliptin/about-sitagliptin/>
- [38] U.S. National Library of Medicine. Acarbose. MedlinePlus Drug Information. 官方药物资料: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a696015.html>
- [39] National Health Service. Side effects of empagliflozin. 官方患者资料: <https://www.nhs.uk/medicines/empagliflozin/side-effects-of-empagliflozin/>
- [40] World Health Organization. Ethics and governance of artificial intelligence for health: guidance on large multi-modal models. Geneva: WHO, 2024. 官方发布说明: <https://www.who.int/news/item/18-01-2024-who-releases-ai-ethics-and-governance-guidance-for-large-multi-modal-models>

版本后记

数字重编版 v1.0由全部16项原始材料重新组织而成。正文、长文网页和PDF共用同一份章节文本；网页目录与翻页目录按实际生成结果建立。第220号仅作为出版视觉与阅读体验的参照，本书不借用其卷号、ISBN、署名或出版日期。

本版的医学证据校订，并不表示所有理论命题已经被验证，也不表示已取得外部临床审稿或正式新版登记。它完成的是一次有记录的结构重编、文字统稿与来源核查。读者发现实质错误时，可按书名、版本与章节反馈；后续修订应留下可比较的记录，而不悄悄把旧结论改写成仿佛从未存在。

保护生命，也让生命重新参与自己的生活。

DEMAI MONOGRAPHS

德麦国际专著 · 第25号

保护生命 也让生命重新生活

不只问指标是否改善
也问行动怎样成为可能
以及被保护的生活为何值得继续

六编三十章 · 五个附录

医学哲学 × 证据边界 × 生活重建

数字重编版 v1.0

ISBN 978-1-970820-33-1

医学哲学与健康教育读物
不替代个体诊疗，不提供自行停药方案